Perfil V3 · código por código

Traumatología

Los 45 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Traumatología, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 9 códigos

4.02.1.001 Artrosis primarias y secundarias

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Artrosis: destrucción progresiva del cartílago; primaria (degenerativa, genética) o secundaria (fracturas intraarticulares, luxaciones crónicas, artritis reumatoide o séptica previa).
- Clínica: dolor mecánico (empeora con el uso, cede con reposo), rigidez matinal <30 min, crepitación, derrame no inflamatorio; Heberden (IFD), Bouchard (IFP), rizartrosis; coxartrosis con dolor inguinal y pérdida de rotación interna.
- Confirmación con radiografía en carga: pinzamiento asimétrico, esclerosis subcondral, osteofitos y geodas, sin osteopenia ni erosiones. Líquido sinovial no inflamatorio (<2.000 leucocitos).
- Tratamiento inicial: baja de peso, ejercicio y fortalecimiento de cuádriceps; paracetamol 1 g c/8 h (hasta 3–4 g/día); AINE breves si no basta (evitar en IRC, úlcera, insuficiencia cardíaca: usar tramadol).
- Infiltración con corticoide intraarticular en brotes; prótesis o artrodesis como última línea (GES endoprótesis total de cadera en mayores de 65 con artrosis severa).
- Seguimiento completo en APS: control de dolor y función, peso y adherencia al ejercicio; derivar a traumatología si hay dolor refractario e incapacidad.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 139

Un paciente de 60 años, sin antecedentes de importancia, consulta por dolor de la rodilla izquierda, de 4 semanas de evolución, que le dificulta la marcha. Al examen físico, su rodilla no tiene alteraciones. **¿Qué otra articulación se debe examinar?**

A) La cadera
B) La sínfisis del pubis
C) La sacroilíaca
D) El tobillo
E) La articulación astragalotarsiana

Respuesta A. Recordar que la patología de cadera puede producir gonalgia (dolor de rodilla).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 5

Un paciente de 77 años presenta dolor inguinal derecho de 2 años de evolución, que aumenta con la marcha, limitándola. Al examen físico se aprecia pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera derecha. **El diagnóstico más probable es:**

A) Necrosis avascular de la cabeza femoral
B) Coxartrosis
C) Hernia foraminal S1
D) Pinzamiento femoroacetabular
E) Estenosis raquimedular

Respuesta B. Dolor inguinal que lleva dos años, aumenta con la marcha y se acompaña de pérdida de la rotación interna y la flexión de la cadera, en un adulto mayor: coxartrosis, la artrosis de cadera.

Pregunta de práctica

Mujer de 58 años con insuficiencia renal crónica estadio 3 y úlcera duodenal activa consulta por artrosis de cadera con dolor que no cede con paracetamol. **¿Cuál es el siguiente paso correcto en el manejo?**

A) Agregar ibuprofeno más omeprazol como protección gástrica
B) Agregar celecoxib, ya que los COX-2 no producen úlcera
C) Tramadol oral, saltando el escalón de los AINE por contraindicación
D) Corticoides orales en dosis bajas como antiinflamatorio alternativo
E) Derivar directamente a cirugía por la complejidad del caso

Respuesta C. Con insuficiencia renal crónica o úlcera péptica activa los AINE están contraindicados, aunque se agregue omeprazol y aunque sean COX-2, que siguen siendo riesgosos para el riñón. El tratamiento salta del paracetamol al tramadol. Los corticoides orales no forman parte de la escalera, y la cirugía es la última línea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 63 años consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. El diagnóstico más probable es:

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta D. Diagnóstico: Bursitis trocantérica (opción D). Parece una bursitis trocantérica clásica.. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 14 · texto original del banco, sin revisar

Pregunta 14 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta Un paciente de 78 años consulta por dolor en ambas ingles, irradiado a los muslos, que inició hace 5 años y que es más intenso al caminar, lo que ha limitado su movilidad en el último tiempo. Se solicita una radiografía AP de pelvis, que se muestra a continuación: ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Displasia de caderas
B) Mestástasis óseas
C) Necrosis avascular de la cabeza femoral bilateral
D) Sacroileítis
E) Coxoartrosis bilateral

Respuesta E. Diagnóstico: Coxoartrosis bilateral (opción E). Es una artrosis de cadera, tanto por la clínica, como por la radiografía.. La artrosis (osteoartritis) es la patología articular más frecuente. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 120 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, con antecedente de displasia de cadera derecha, tratada con cirugía abierta en su infancia, consulta por dolor muy intenso en la cadera izquier- da, que la hace cojear permanentemente. Al examen físico presenta acortamiento de 25

A) Tratamiento sintomático de la artrosis
B) Indicar tratamiento kenesioterapéutico
C) Realizar osteotomía acetabular
D) Instalar prótesis total de cadera
E) Compensar el acortamiento con calzado con realce

Respuesta D. En mi opinión tiene indicación de reemplazo articular. Pero la decisión exacta co- rresponde al especialista, según cada caso.

4.02.1.002 Displasia congénita de cadera

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik · Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: sexo femenino, presentación podálica, antecedente familiar de primer grado. Problema de salud GES.
- Menor de 3 meses: Ortolani (reduce con resalto) y Barlow (luxa la cadera inestable); mayor de 3 meses: abducción limitada <60° y signo de Galeazzi.
- Confirmación: ecografía bajo los 3 meses si hay hallazgos; radiografía de pelvis a los 3 meses a todos los lactantes. Displasia: índice acetabular >30°, núcleo o metáfisis fuera del cuadrante ínfero-interno (Hilgenreiner-Perkins), ruptura del arco de Shenton.
- Tratamiento inicial: derivar a traumatología infantil; menor de 6 meses arnés de Pavlik (flexión 90–100° con abducción moderada, nunca forzada por riesgo de necrosis).

- Si falla o el diagnóstico es tardío: reducción bajo anestesia con yeso pelvipédico o reducción cruenta. Sin tratamiento evoluciona a artrosis precoz y cojera.
- Seguimiento: derivar a ortopedia infantil; el doble pañal no es tratamiento.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 137

Niño diagnosticado de displasia de cadera a los 6 meses de vida, mediante radiografía que muestra luxación del extremo proximal del fémur izquierdo. **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Doble pañal
B) Correas de Pavlik
C) Yeso con fijador
D) Osteotomía periacetabular tipo Ganz
E) Reducción abierta y fijación con osteosíntesis

Respuesta B. A los 6 meses todavía está dentro de la ventana en que el arnés de Pavlik funciona como tratamiento de elección. La cirugía y la osteotomía quedan para el niño mayor o para cuando el arnés fracasa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 7

Niño de 3 meses de edad, radiografía de pelvis que muestra displasia de cadera izquierda, con índice acetabular de 36 grados. **¿Cuál es la indicación más adecuada?**

A) Ejercicios de rotación y compresión
B) Bota larga bilateral de yeso, con yugo
C) Yeso pelvipédico
D) Uso de doble pañal
E) Arnés de Pavlik

Respuesta E. Un índice acetabular de 36 grados a los 3 meses está sobre el corte normal de 30, y confirma la displasia. En un lactante de esta edad, el tratamiento es arnés de Pavlik.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 130

Niño de 9 años con cojera indolora progresiva de 3 semanas. Rx de cadera: aplanamiento y fragmentación de la cabeza femoral derecha. ¿Cuál es el diagnóstico y conducta? **¿Cuál es el diagnóstico y conducta?**

A) Enfermedad de Legg-Calvé-Perthes: derivar a ortopedia infantil
B) Sinovitis transitoria: reposo y AINEs
C) Artritis séptica: hospitalizar y cirugía
D) Displasia del desarrollo de cadera: arnés de Pavlik
E) Osteosarcoma: biopsia urgente

Respuesta A. Necrosis avascular de la cabeza femoral en un niño de 4 a 10 años, con radiografía de fragmentación y aplanamiento: enfermedad de Perthes. Se deriva a ortopedia para decidir tratamiento conservador o quirúrgico.

4.02.1.003 Escoliosis y deformidades vertebrales

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Escoliosis: desviación lateral de la columna con rotación vertebral; sospechar ante asimetría de hombros, escápulas o talle, sobre todo en niñas adolescentes.
- Test de Adams: giba costal al inclinarse hacia adelante indica escoliosis estructural (la actitud postural no tiene giba).
- Ante sospecha, radiografía de columna completa de pie para medir el ángulo de Cobb.
- Conducta según Cobb: <30° observación y ejercicios; 30–50° corsé; >50° cirugía (artrodesis).
- Banderas rojas: dolor, curva torácica izquierda, déficit neurológico o progresión rápida obligan a buscar causa secundaria (tumor, siringomielia).
- Seguimiento: derivar a traumatología infantil para control radiológico durante el crecimiento.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 122

Una paciente de 63 años presenta dolor dorsal intenso, que inició hace 5 días, en relación a un esfuerzo en flexión y que ha aumentado, limitando significativamente sus actividades de la vida diaria. Tiene antecedente de una fractura de muñeca hace un año, que requirió tratamiento quirúrgico. Al examen físico se aprecia adolorida, con signos vitales normales, dolor a la movilización activa y pasiva de su columna dorsal, que limita los movimientos de flexo-extensión. A la inspección la curvatura dorsal se observa redonda, sin cifosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hernia del núcleo pulposo
B) Tuberculosis vertebral
C) Espondilolistesis dorsal
D) Espondilosis dorsal
E) Fractura vertebral

Respuesta E. Dolor dorsal agudo tras un esfuerzo mínimo en una mujer con fractura de muñeca previa: fractura vertebral por aplastamiento osteoporótica. Dos fracturas por fragilidad: osteoporosis clínica, que se trata aunque no haya DEXA.

Pregunta de práctica

Una niña de 13 años es llevada por su madre porque se le nota un hombro más alto. Al inclinarse hacia adelante se ve una giba costal derecha. La radiografía de columna muestra una escoliosis torácica con un ángulo de Cobb de 38 grados. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Solo ejercicios y observación
B) Corsé
C) Artrodesis de columna
D) Tranquilizar: es una actitud escoliótica
E) Reposo en cama

Respuesta B. La giba costal con el test de Adams confirma una escoliosis verdadera, no una actitud postural. Con una desviación de 38 grados, entre 30 y 50, corresponde corsé. Los ejercicios y la observación son para menos de 30 grados, y la cirugía para más de 50.

4.02.1.004 Infecciones osteoarticulares

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis · Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Artritis séptica: monoartritis aguda con fiebre y dolor intenso a la movilización activa y pasiva de una articulación grande (rodilla, cadera, hombro); S. aureus es el agente principal; gonococo en joven sexualmente activo.
- Confirmación: artrocentesis antes del antibiótico: líquido turbio >50.000 leucocitos, >90 % PMN, glucosa <50 % de la glicemia; Gram (poco sensible) y cultivo; hemocultivos ×2. Los cristales no descartan infección.
- Osteomielitis y espondilodiscitis: dolor óseo localizado, fiebre, VHS/PCR altas; RM con gadolinio es el examen de elección (la radiografía se altera tarde); hemocultivos y biopsia si son negativos.
- Tratamiento inicial: hospitalizar, antibiótico EV empírico (cefazolina 2 g c/8 h o cloxacilina; vancomicina si riesgo de SAMR; ceftriaxona si gonococo o gramnegativos) y drenaje articular urgente.
- La cadera es una emergencia quirúrgica (riesgo de necrosis avascular). Diferenciar de bursitis (superficial, movilidad pasiva conservada). Infección protésica: recambio y rifampicina.
- Seguimiento: derivar a traumatología para drenaje y control; antibiótico prolongado (3–6 semanas).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 126

Hombre de 60 años con dolor, calor y aumento de volumen en la rodilla derecha de inicio súbito. Artrocentesis: líquido turbio, 50.000 GB con 90% PMN. Gram: cocos gram positivos en racimos. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Artritis séptica por Staphylococcus aureus
B) Gota aguda
C) Artritis reumatoide
D) Pseudogota (artritis por pirofosfato)
E) Artritis reactiva

Respuesta A. Artritis séptica confirmada por recuento sinovial de 50.000 leucocitos/mm³ con 90% de neutrófilos y tinción de Gram demostrando cocos grampositivos en racimo, compatible con Staphylococcus aureus. Requiere drenaje articular urgente y antibióticos antiestafilocócicos EV.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 167

Paciente de 67 años, con antecedente de pielonefritis tratada hace 2 meses, presenta dolor lumbar desde hace 1 mes que se ha ido intensificando, asociado a sensación febril durante los últimos días. Al examen físico tiene temperatura de 38 °C y dolor a la palpación de la zona lumbar media. La radiografía lumbar muestra aplastamiento de L2 y L3, con imagen radiolúcida alrededor del disco intervertebral. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Osteosarcoma
B) Pielonefritis aguda
C) Osteoma osteoide
D) Espondilodiscitis
E) Espondilolistesis

Respuesta D. Lumbago progresivo con fiebre tras una bacteriemia de origen urinario, con erosión de dos platillos vertebrales contiguos y del disco entre ellos, es espondilodiscitis (siembra hematógena). La infección cruza el disco; los tumores típicamente lo respetan. Se confirma con resonancia, hemocultivos y biopsia o punción guiada.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Tratamiento ATB de una osteomielitis de cadera en niño de 10 años:

A) Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina
C) Ampicilina
C) Staphylococcus aureus
D) Streptococcus pneumoniae
E) Escherichia coli

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Cefazolina Cefa pq no tenia factores de riesgo a sarm, como tto empírico (decía específicamente empírico la pregunta, lo mejor es partir asumiendo que es SAMR como es una infección grave con Vanco) b. Vancomicina (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atenció

4.02.1.005 Lumbago mecánico

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis · Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbago mecánico: el más frecuente; dolor que aumenta con el movimiento y cede con el reposo, por debilidad de musculatura axial; sin irradiación bajo la rodilla.
- Diagnóstico clínico: descartar banderas rojas (edad >50 o <20, cáncer, fiebre, baja de peso, trauma mayor, déficit neurológico, anestesia en silla de montar o alteración esfinteriana). Sin alarma no se piden imágenes.
- Dolor inflamatorio (mejora con ejercicio, empeora con reposo, rigidez matinal prolongada) orienta a espondiloartritis.
- Tratamiento: AINE o paracetamol, calor local, educación y mantener la actividad; evitar reposo prolongado en cama; kinesioterapia y fortalecimiento de musculatura lumbar y abdominal cuando cede el dolor agudo.
- Evoluciona favorablemente en 4–6 semanas; imágenes si persiste >4–6 semanas pese a tratamiento o aparecen banderas rojas.
- Seguimiento completo en APS: control clínico, ejercicios de fortalecimiento y ergonomía para prevenir recurrencias.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 29

Un paciente de 40 años, oficinista, estuvo moviendo muebles durante 2 días, evolucionando luego con intenso dolor lumbar, que le impide realizar sus actividades. Al examen físico se aprecia muy adolorido, con dificultades para subirse a la camilla y para caminar, tiene IMC de 28 y se observa una contractura muscular a nivel lumbar, con dolor ante todos los movimientos de la columna lumbar, sin signos de irritación nerviosa. **Además de administrar analgésicos, la indicación más adecuada es:**

A) Resonancia magnética nuclear
B) Radiografía de columna lumbosacra
C) Kinesioterapia motora por 10 días
D) Reposo en cama por 5 días
E) Reposo laboral por 3 días

Respuesta E. Es un lumbago mecánico agudo, sin signos de irritación nerviosa. Se maneja con analgesia y reposo relativo, no en cama, que aquí es un breve reposo laboral. La kinesioterapia se inicia cuando el dolor cede, para fortalecer la musculatura y evitar recurrencias, y no se piden imágenes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 95

Hombre de 45 años con lumbalgia mecánica de 5 días de evolución, sin irradiación, sin signos de alarma. EF: dolor a la palpación paravertebral lumbar, sin déficit neurológico. ¿Cuál es el manejo más adecuado? **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Analgesia (AINEs o paracetamol) + kinesioterapia activa; no reposo en cama
B) Reposo absoluto por 7 días
C) Cirugía de columna
D) Infiltración epidural de corticoides
E) Resonancia magnética urgente

Respuesta A. Lumbalgia mecánica aguda sin alarma: AINE por corto plazo, actividad física progresiva y kinesioterapia. El reposo en cama prolonga la incapacidad, y no hay indicación de imagen en la fase aguda.

4.02.1.006 Lumbociática radicular

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática: dolor lumbar irradiado a la pierna bajo la rodilla, habitualmente por hernia del núcleo pulposo; Lasègue positivo.
- L5 (hernia L4-L5): dolor al dorso del pie y ortejo mayor, debilidad de dorsiflexión del hallux, reflejos normales. S1 (L5-S1): planta y borde lateral del pie, debilidad de flexión plantar, aquiliano disminuido. L4: reflejo rotuliano disminuido.
- Urgencia: anestesia en silla de montar, retención urinaria o incontinencia (cauda equina) o déficit motor progresivo → derivación urgente y RM.
- Manejo inicial sin déficit: analgesia (AINE, paracetamol), mantenerse activo, sin reposo en cama, por 4–6 semanas.
- RM solo con banderas rojas o falla del tratamiento médico; cirugía si fracasa el manejo médico bien llevado o hay déficit neurológico agudo.
- Seguimiento: derivar a traumatología o neurocirugía si persiste o hay déficit.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 139

Un paciente de 60 años consulta por lumbago intenso de 2 semanas de evolución, asociado a disfunción eréctil, que no ha respondido al tratamiento con analgésicos orales. Al examen físico, presenta limitación a los movimientos de flexoextensión y flexión lateral de la columna lumbar, debido al dolor. Además, se objetiva anestesia de la zona perineal. El diagnóstico más probable corresponde a un síndrome: **El diagnóstico más probable corresponde a un síndrome:**

A) Lumbociático
B) Facetario lumbar
C) De compresión medular
D) Sacroilíaco
E) De cauda equina

Respuesta E. Tanto la compresión del cono medular como la de la cauda equina se presentan con anestesia en silla de montar y disfunción sexual. De las opciones, la más razonable es el síndrome de cauda equina, porque la compresión medular clásica tiene compromiso motor y sensitivo sin tanta afectación pudenda.

4.02.1.007 Pie plano

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Pie plano flexible: el arco aparece al pararse en puntillas o con la extensión del hallux; es fisiológico en niños pequeños y suele corregirse con el crecimiento.
- Pie plano flexible asintomático: tranquilizar; no requiere plantillas ni zapatos ortopédicos (no cambian la evolución).
- Sospechar patológico si es rígido (no se forma arco en puntillas), doloroso, unilateral o progresivo: descartar coalición tarsal, astrágalo vertical u otras causas.
- Manejo inicial del sintomático: calzado adecuado, ejercicios de fortalecimiento, control de peso y analgesia.
- Derivar a traumatología infantil el pie plano rígido, doloroso, unilateral o progresivo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 76

Recién nacido con pie equino varo bilateral (CTEV) detectado al nacimiento. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Control en el próximo control de salud infantil
B) Derivar a ortopedia infantil para inicio de método Ponseti
C) Hospitalizar para cirugía inmediata
D) Observación domiciliaria: se corrige solo
E) Kinesiología ambulatoria y férulas

Respuesta B. Pie equino varo congénito: derivación urgente a ortopedia pediátrica para iniciar el método de Ponseti, con yesos seriados y tenotomía percutánea del Aquiles si hace falta. Debe comenzar en las primeras semanas de vida y es corregible con tratamiento precoz.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 159

Niño de 8 años con pie plano flexible asintomático. El arco plantar aparece al pararse en puntillas. No tiene dolor ni limitación funcional. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Tranquilizar a los padres: pie plano flexible fisiológico, no requiere plantillas ni tratamiento
B) Plantillas correctoras
C) Derivar a ortopedia
D) Fisioterapia intensiva
E) Cirugía correctora

Respuesta A. El pie plano flexible (el arco se forma en puntillas) y asintomático es una variante normal que no requiere plantillas: no cambian la evolución. Se deriva solo si es rígido, doloroso, unilateral o progresivo, para descartar coalición tarsal u otras causas.

4.02.1.008 Síndrome de hombro doloroso

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis · Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- Causa más común: síndrome de manguito rotador (supraespinoso) por pinzamiento subacromial y movimientos repetitivos; dolor nocturno al acostarse sobre el hombro.
- Examen: arco doloroso entre 60° y 120°, Neer y Hawkins positivos, Jobe evalúa supraespinoso; movilidad pasiva conservada. Ecografía es el examen más costo-efectivo si se requiere.
- Capsulitis adhesiva (hombro congelado): limitación activa y pasiva, fase dolorosa y luego rigidez; tratamiento con corticoides y kinesioterapia intensiva.
- Debilidad marcada o imposibilidad de elevar el brazo y cabeza humeral ascendida sugieren rotura completa del manguito.
- Tratamiento inicial: reposo relativo, AINE, frío y kinesioterapia motora.
- Seguimiento: derivar a traumatología si no responde, hay sospecha de rotura completa o capsulitis.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 82

Una paciente de 43 años, secretaria, consulta porque, desde hace dos semanas, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha ido limitando sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación del brazo derecho, por sobre el hombro. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Capsulitis adhesiva de hombro
B) Tendinopatía del manguito rotador
C) Disyunción acromioclavicular
D) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
E) Hernia cervical con compresión radicular

Respuesta B. Es una tendinopatía del manguito rotador clásica. La capsulitis adhesiva tiene más dolor y una clara limitación de los movimientos, por el dolor y, en la última fase, por fibrosis. La tendinopatía bicipital da dolor en la cara anterior del hombro.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 127

Hombre de 55 años con dolor en el hombro derecho al elevar el brazo entre 60-120° (arco doloroso). Prueba de Neer y Hawkins positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de pinzamiento subacromial (manguito rotador)
B) Luxación glenohumeral
C) Capsulitis adhesiva (hombro congelado)
D) Artritis reumatoide de hombro
E) Fractura de clavícula

Respuesta A. Arco doloroso de 60 a 120 grados con Neer y Hawkins positivos es un síndrome de pinzamiento subacromial, por tendinitis o desgarro del manguito rotador. Tratamiento: kinesioterapia y antiinflamatorios, con o sin corticoides locales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 119

Una paciente de 58 años presenta dolor en el hombro derecho desde hace 4 meses, que aumenta con la actividad física. Refiere que es intenso, con EVA 6/10, empeorando en la noche. Al examen físico, la movilidad pasiva está conservada, pero presenta limitación en la movilidad activa, especialmente para elevar el brazo por encima del hombro y en los movimientos de rotación interna. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Artrosis acromioclavicular
B) Artrosis glenohumeral
C) Síndrome del manguito rotador
D) Capsulitis adhesiva
E) Tendinopatía bicipital

Respuesta C. Es un síndrome del manguito rotador clásico. La capsulitis adhesiva, en cambio, se caracteriza por la limitación tanto de la movilidad pasiva como de la activa.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 68

Un hombre de 42 años presenta dolor en el hombro derecho, de dos semanas de evolución, que inició en relación a un partido de tenis y que limita sus actividades, en especial, los movimientos de abducción y elevación. Al examen físico tiene dolor a la palpación subacromial, con dolor a la abducción y elevación del hombro, que dificulta estos movimientos, por sobre 80°. Se solicitan radiografías de hombro, que muestran esclerosis del acromion y leve ascenso de la cabeza humeral. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Tendinitis cálcica
B) Pinzamiento subacromial
C) Rotura completa del tendón del supraespinoso
D) Capsulitis adhesiva
E) Tendinitis bicipital

Respuesta C. Parece un síndrome del manguito rotador, pero el ascenso de la cabeza humeral orienta a la rotura del tendón del supraespinoso. La capsulitis adhesiva limitaría totalmente los movimientos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 101 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 31 años, secretaria, consulta por dolor en el hombro derecho, que ha aumentado en el último tiempo. Ella refiere que es más intenso en la noche y que aparece especialmente al levantar el codo por sobre el hombro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Tendinitis del manguito rotador
B) Hernia del núcleo pulposo cervical
C) Artrosis glenohumeral
D) Tendinitis de la cabeza larga del bíceps
E) Capsulitis adhesiva de hombro

Respuesta A. Diagnóstico: Tendinitis del manguito rotador (opción A). Era una tendinitis del manguito rotador clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 126 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 45 años presenta dolor en el hombro derecho, que es mayor en la noche y que presenta impotencia funcional, que dificulta sus actividades. Al examen físico presenta dolor a la flexión y a la abducción tanto activa, como pasiva, del hombro derecho. La conducta más adecuada es:

A) AINES y reposo
B) AINES y kinesioterapia
C) Cabestrillo
D) Infiltración con corticoides
E) Cirugía

Respuesta B. Es un síndrome del manguito rotador. Probablemente esta evolucionando a una capsulitis adhesiva (dolor al movimiento pasivo). Se debe dar analgésicos y movilizar precozmente, para evitar la anquilosis.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 60 años, con antecedente de hipertensión arterial y diabetes mellitus ambas en tratamiento farmacológico, consulta por dolor en hombro derecho de varios meses de evolución, el cual aumenta de intensidad en la noche, asociado a impotencia funcional. Al examen físico sin dolor a la movilización pasiva y con dolor a la abducción y rotación externa de hombro derecho. El diagnóstico más probable es:

A) Tendinopatía bicipital
B) Osteoartritis de hombro
C) Tendinopatía deltoídea
D) Tendinopatía del manguito rotador
E) Disyunción acromioclavicular leve

Respuesta D. El dolor mayor en la noche es característico. Además es la causa más frecuente de dolor en el hombro.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 140 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 58 años, consulta porque, desde hace una semana, presenta dolor en el hombro derecho, que es más intenso durante la noche y que empeora con los movimientos del mismo, por lo que ha limitado sus actividades normales. El dolor aumenta con la abducción y con la elevación sobre 90° del brazo derecho. Al examen físico tiene movilidad completa del hombro, con dolor en las maniobras descritas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Capsulitis adhesiva de hombro
B) Patología del manguito rotador
C) Artritis séptica
D) Tendinopatía de la cabeza larga del bíceps braquial
E) Artrosis de la articulación glenohumeral

Respuesta B. Diagnóstico: Patología del manguito rotador (opción B). Es un síndrome de manguito rotador clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

4.02.1.009 Tumores óseos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante dolor óseo sordo o nocturno persistente que no cede con reposo, aumento de volumen, fractura patológica con trauma mínimo o hallazgo radiológico; un «esguince» que no mejora obliga a radiografía.
- Diagnóstico orientado por edad, ubicación (epífisis, metáfisis, diáfisis) y aspecto radiológico.
- Signos de malignidad: bordes mal definidos, cortical rota, invasión de partes blandas, reacción perióstica compleja (sol naciente, triángulo de Codman, telas de cebolla).
- Benignos: osteocondroma (el más frecuente, bulto indoloro, observar); osteoma osteoide (dolor nocturno que cede con aspirina/AINE, nidus radiolúcido).
- Malignos: osteosarcoma (adolescente, metáfisis cerca de la rodilla); Ewing (niño, diáfisis o pelvis, telas de cebolla); células gigantes (adulto 40–50, epífisis). En adultos, las metástasis óseas son más frecuentes que los tumores primarios.
- Manejo inicial: analgesia, evitar carga si hay riesgo de fractura y derivar a centro especializado para RM, TAC de tórax y biopsia.

PREGUNTAS (12)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 18

Sd compresión medular en paciente con Ca de próstata y Mtt ósea. **Estudio:**

A) Rnm columna con gadolinio
B) Mielografía
C) Cintigrama óseo
D) Radiografía columna
E) TAC

Respuesta A. Ante la sospecha de compresión medular neoplásica, el estudio de elección es la resonancia magnética de columna completa con gadolinio, coordinada en paralelo con dexametasona EV en dosis altas, que se inicia de inmediato sin esperar la imagen.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 154

Un paciente de 15 años sufre una torsión de rodilla derecha, siendo diagnosticado de un esguince, por lo que se indica inmovilizador de rodilla. Sin embargo, no mejora luego de 10 días, sino que, por el contrario, el dolor ha ido en aumento y no responde bien a la analgesia con naproxeno y ketorolaco. Al examen físico, presenta dolor a los movimientos de flexoextensión de la rodilla y a la palpación en la zona proximal y medial de la tibia derecha, sin signo de bostezo al varo ni al valgo. Se solicita una radiografía de rodilla, que muestra aspecto heterogéneo de la tibia proximal, con reacción perióstica. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Osteosarcoma
B) Fractura
C) Osteomielitis
D) Esguince severo de rodilla
E) Hematoma en organización

Respuesta A. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Aspecto heterogéneo de la metáfisis con reacción perióstica en un adolescente corresponde a un osteosarcoma.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 9

Un adolescente de 16 años presenta dolor en la rodilla derecha, luego de haberse golpeado. Al examen físico se palpa aumento de volumen de consistencia ósea, por lo que se solicita una radiografía, que muestra una lesión ósea herterogénea, ubicada en el extremo distal del fémur, con disrupción de la cortical y zonas líticas, con otras de aumento de la densidad. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Osteocondroma
B) Tumor de células gigantes
C) Osteosarcoma
D) Displasia ósea fibrosa
E) Quiste óseo

Respuesta C. Tumor óseo de aspecto maligno. Por la ubicación y la edad es un osteosarcoma, que aparece en adolescentes y adultos mayores. El sarcoma de Ewing es diafisiario.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 94

Un paciente de 19 años, sin antecedentes, hace un mes sufre golpe contuso en rodilla izquierda mientras jugaba futbol, tras lo cual ha permanecido con dolor el cual ha aumentado en las últimas semana, asociado a aumento de volumen duro. Se solicita radiografía de rodilla que muestra lesión de gran tamaño en metáfisis y diáfisis de fémur, asociado a compromiso cortical. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Sarcoma de Ewing
B) Osteosarcoma
C) Osteoma osteoide
D) Sarcoma de partes blandas
E) Tumor de células gigantes

Respuesta B. Por la edad es un osteosarcoma. El tumor de células gigantes es de los 40 a los 55 años. El sarcoma de Ewing es de localización diafisiaria, no metafisiaria.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 39

Una mujer de 18 años presenta traumatismo en la rodilla derecha, siendo diagnosticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evoluciona con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Osteomielitis del fémur distal
B) Osteosarcoma osteogénico
C) Fractura del fémur distal, con callo óseo
D) Osteocondroma
E) Hematoma calcificado

Respuesta B. La reacción perióstica y el compromiso de partes blandas son clásicos de un tumor maligno, y por la edad lo más probable es un osteosarcoma. En el EUNACOM es frecuente que se dé el antecedente de un trauma aunque no tenga relación con el tumor, porque el golpe es lo que hace que el paciente se palpe la lesión.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 90

Un adolescente de 17 años presenta un golpe en la rodilla izquierda, evolucionando con dolor en la cara anterior de la rodilla, que es manejado con analgésicos, sin embargo, no responde adecuadamente, por lo que se solicita una radiografía de rodilla y pierna, que muestra discontinuidad de la cortical de la diáfisis de la tibia, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular de 2 cm y algunas zonas osteoblásticas con otras osteolíticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fractura en maduración
B) Hematoma calcificado
C) Osteomielitis aguda
D) Tumor óseo maligno
E) Condromalacia

Respuesta D. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía. Cortical interrumpida, calcificación de partes blandas, reacción perióstica triangular y zonas osteoblásticas junto a otras osteolíticas indican un tumor óseo maligno.

Pregunta de práctica

Un niño de 10 años consulta por dolor en el brazo. La radiografía muestra una lesión en la diáfisis del húmero, de aspecto heterogéneo, con rotura de la cortical y extensión a partes blandas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Osteosarcoma
B) Sarcoma de Ewing
C) Tumor de células gigantes
D) Osteocondroma
E) Enfermedad de Paget

Respuesta B. Un niño con una lesión maligna en la diáfisis es un sarcoma de Ewing hasta que se demuestre lo contrario. El osteosarcoma prefiere la metáfisis, el tumor de células gigantes es de adultos, el osteocondroma es benigno y el Paget es de adultos mayores.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 53 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 17 años presenta traumatismo en la rodilla izquierda, siendo diagnos- ticada de esguince de rodilla, el que se maneja con reposo y antiinflamatorios. Evolucio- na con dolor persistente, por lo que consulta nuevamente. Se solicita una radiografía de rodilla que muestra reacción perióstica y compromiso de partes blandas. El diagnóstico más probable es:

A) Osteomielitis del fémur distal
B) Osteosarcoma osteogénico
C) Fractura del fémur distal, con callo óseo
D) Osteocondroma
E) Hematoma en organización

Respuesta B. Diagnóstico: Osteosarcoma osteogénico (opción B). Es un osteosarcoma clásico, aunque la pregunta estaba horriblemente redactada.. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 160 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con traumatismo de rodilla persistente; radiografía muestra reacción perióstica y aumento de densidad en tibia proximal. ¿Diagnóstico más probable?

A) Fractura de estrés tibial
B) Osteosarcoma
C) Osteomielitis crónica
D) Encondroma
E) Quiste óseo simple

Respuesta B. Diagnóstico: Osteosarcoma (opción B). Osteosarcoma. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar

Un niño de 13 años consulta por dolor y aumento de volumen, en relación a la pierna izquierda, que ha ido en aumento y lo hace cojear. Tiene antecedente de traumatismo en la zona. Se solicitan una radiografía y una resonancia magnética nuclear, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Osteocondroma
B) Osteosarcoma
C) Sarcoma de partes blandas
D) Tumor de células gigantes
E) Sarcoma de Ewing

Respuesta E. Es una pregunta difícil, pero que ya se había realizado antes y se trata de un sarcoma de Ewing clásico, especialmente por la edad (menores de 15 años es lo más frecuente, aunque incluso se ve en adultos jóvenes) y por localización diafisiaria. Eso sí, también podría ser un sarcoma de partes blandas (más frecuente desde los 15 años), pero la clara afectación ósea de la RMN y también de la Rx hace

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar

Adolescente de 15 años con dolor en la rodilla derecha de 3 meses de evolución. Refiere haber tenido un golpe previo que no mejora. Radiografía: masa osteolítica con reacción perióstica en triángulo de Codman en la metáfisis distal del fémur. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura patológica
B) Osteomielitis crónica
C) Sarcoma de Ewing
D) Osteosarcoma
E) Condrosarcoma

Respuesta D. Osteosarcoma: masa osteolítica en METÁFISIS de huesos largos (fémur distal / tibia proximal) en adolescentes + triángulo de Codman (reacción perióstica) = osteosarcoma. El Sarcoma de Ewing ocurre en DIÁFISIS y produce patrón "cebolla". Ambos tratados con cirugía + quimioterapia.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 161 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con traumatismo de rodilla; radiografía muestra reacción perióstica, lisis cortical triangular y aumento de densidad en partes blandas. ¿Diagnóstico más probable?

A) Metástasis ósea
B) Linfoma óseo primario
C) Condrosarcoma
D) Osteomielitis aguda
E) Tumor óseo maligno primario

Respuesta E. Diagnóstico: Tumor óseo maligno primario (opción E). Tumor óseo maligno primario. Los tumores óseos se diagnostican principalmente con la radiografía, que aporta información crucial para diferenciar benignos de malignos. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Situaciones clínicas de urgencia 15 códigos

4.02.2.001 Complicaciones de los traumatismos: sistémicas y vasculares

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.3 Síndrome Compartimental Agudo: Signos Cardinales (5P), Presión Intracompartimental & Fasciotomía Urgente · Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome compartimental (horas): dolor desproporcionado que no cede con analgésicos, dolor al estiramiento pasivo (signo más precoz), compartimento tenso; la ausencia de pulso es tardía. Típico con yeso circular o trauma de alta energía.
- Conducta inmediata: retirar yeso y vendajes; si no mejora, fasciotomía urgente. Nunca yeso circular en fractura reciente.
- Embolia grasa (horas a 48 h, fracturas de huesos largos): distrés respiratorio, compromiso de conciencia y petequias en tórax, cuello y axilas; manejo de soporte.
- TEP (días): disnea súbita y dolor pleurítico; angioTAC (el dímero D no sirve en el traumatizado); trombólisis si hay shock. Prevenir con tromboprofilaxis y movilización.

- Lesión vascular: 6 P (dolor, palidez, ausencia de pulsos, parestesias, parálisis, frialdad) y hemorragia pulsátil; compresión directa, torniquete solo si es exanguinante; derivar a cirugía vascular.
- Shock hipovolémico en fracturas de fémur (hasta 1,5 L) y pelvis: ABC y reposición de volumen. Seguimiento: derivar.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 131

Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, sufriendo una fractura del extremo distal del radio izquierdo, la que es manejada ortopédicamente, con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas, evoluciona con intenso dolor, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultades para mover los dedos. Al examen físico, se objetivan dedos con llene capilar enlentecido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome de dolor locorregional complejo
B) Lesión de la arteria radial
C) Trombosis venosa profunda
D) Compresión del nervio mediano
E) Síndrome compartimental

Respuesta E. Dolor intenso que no responde a analgesia a pocas horas del yeso, con dificultad para mover los dedos y llene capilar enlentecido, es un síndrome compartimental.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 131

Una paciente de 62 años sufre una caída a nivel, con una fractura del extremo distal del radio izquierdo, que es manejada ortopédicamente con un yeso braquiopalmar. A las 5 horas evoluciona con dolor intenso, EVA 10/10, que no responde a la analgesia y se asocia a dificultad para mover los dedos. Al examen físico, los dedos tienen llene capilar enlentecido.
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome de dolor locorregional complejo
B) Lesión de la arteria radial
C) Trombosis venosa profunda
D) Compresión del nervio mediano
E) Síndrome compartimental

Respuesta E. Dolor desproporcionado que no cede con analgesia, dificultad para mover los dedos y llene capilar lento pocas horas después de enyesar una fractura son un síndrome compartimental. Se debe abrir o retirar el yeso de inmediato y, si no mejora, fasciotomía.

Pregunta de práctica

Un paciente con fractura de fémur tratada hace tres días presenta en forma súbita disnea intensa y desaturación. **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el examen de elección?**

A) Embolia grasa; dímero D
B) Tromboembolismo pulmonar; angiotac de tórax
C) Tromboembolismo pulmonar; dímero D
D) Síndrome compartimental; fasciotomía inmediata
E) Neumonía aspirativa; radiografía de tórax

Respuesta B. El TEP aparece días después de una fractura, con disnea o dolor torácico súbito, y el examen de elección es el angiotac de tórax. El dímero D no es útil porque la fractura ya lo eleva. La embolia grasa aparece en las primeras horas, con tríada de distrés, compromiso de conciencia y petequias.

Pregunta de práctica

Una mujer de 55 años consulta 2 meses después de una fractura de muñeca tratada con yeso. Refiere dolor quemante en la mano, que se agrava con el roce de la ropa y al mover los dedos. Tiene la piel de la mano brillante, con cambios de color y de vello, y las uñas frágiles. La radiografía muestra osteoporosis moteada. No hay fiebre ni lesión de la piel. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome compartimental agudo
B) Distrofia simpático refleja
C) Contractura isquémica de Volkmann
D) Osteomielitis
E) Trombosis venosa profunda

Respuesta B. Dolor urente con alodinia, cambios tróficos y osteoporosis moteada semanas a meses después de la fractura es una distrofia simpático refleja, o síndrome de dolor regional complejo. El síndrome compartimental aparece en horas y la contractura de Volkmann se caracteriza por la mano en garra.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 52 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 27 años sufre una fractura cerrada de antebrazo, que es manejada con un valva de yeso braquiopalmar. A las 5 horas presenta aumento del dolor y edema de la extremidad. El diagnóstico más probable es:

A) Trombosis venosa profunda
B) Síndrome compartimental
C) Distrofia simpático refleja
D) Alergia al yeso
E) Síndrome de túne carpiano agudo

Respuesta B. Por el corto tiempo de evolución y el dolor es síndrome compartimental. Además es clásico de las Fx de antebrazo. Falta información

4.02.2.002 Disyunción-fractura del niño

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En el niño, la fisis (cartílago de crecimiento) es más débil que los ligamentos: un trauma que en el adulto da esguince puede dar disyunción epifisaria.
- Sospechar ante dolor e impotencia funcional con dolor a la palpación sobre la fisis tras trauma, aunque la radiografía sea normal.
- Clasificación de Salter-Harris: I (solo fisis), II (fisis y metáfisis, la más frecuente), III (fisis y epífisis), IV (atraviesa metáfisis, fisis y epífisis), V (compresión de la fisis).
- Tipos I y II no desplazados: inmovilización con yeso o valva 3–4 semanas; también fracturas en rodete (torus) y en tallo verde se tratan con inmovilización.
- Tipos III, IV y V, desplazadas o intraarticulares: derivar a traumatología infantil (reducción anatómica) por riesgo de detención del crecimiento y deformidad.
- Seguimiento: control clínico y radiológico hasta consolidar y vigilar dismetría o deformidad angular; pensar en maltrato si el mecanismo no concuerda.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 178

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en la cadera izquierda y claudicación progresiva que actualmente le impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. La radiografía AP de pelvis y caderas muestra desplazamiento posteroinferior de la epífisis femoral proximal izquierda respecto de la metáfisis, con ensanchamiento de la fisis. **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello del fémur
D) Luxación de la cadera izquierda
E) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Respuesta B. Adolescente obeso con dolor de cadera o rodilla, claudicación y deslizamiento de la epífisis femoral sobre la metáfisis es una epifisiolisis (disyunción a través de la fisis). Se suspende la carga y se deriva para fijación in situ urgente; no se intenta reducir. La necrosis avascular es su complicación.

4.02.2.003 Esguince grado1 (acromioclavicular, dedos, rodilla y tobillo)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince · Tema 12.9 Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

QUÉ HAY QUE SABER

- Esguince: lesión ligamentosa; grado I distensión leve con dolor sin equimosis ni inestabilidad; II rotura parcial con equimosis; III rotura total con inestabilidad.
- Tobillo: reglas de Ottawa; pedir radiografía si hay dolor en borde posterior o punta de maléolos, base del 5° metatarsiano o navicular, o incapacidad de dar 4 pasos. Si no cumple, no requiere radiografía.
- Rodilla: grado I del colateral medial con dolor al valgo sin bostezo y tope firme; Lachman y cajón negativos. Acromioclavicular grado I: dolor local sin desplazamiento de la clavícula. Dedos: dolor en la interfalángica sin

inestabilidad.

- Tratamiento: reposo relativo, hielo, compresión, elevación (RICE), AINE, movilización y carga precoz según tolerancia; sin inmovilización rígida (cabestrillo breve en acromioclavicular, sindactilia en dedos).
- Rehabilitación propioceptiva y fortalecimiento para evitar recidiva e inestabilidad crónica.
- Seguimiento completo: control en 1–2 semanas; si no mejora o el dolor aumenta, reevaluar con radiografía (fractura, tumor) o derivar.

PREGUNTAS (3)

Pregunta de práctica

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
B) Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
C) Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
D) Fractura de calcáneo; radiografía de pie
E) Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

Respuesta B. El dolor súbito en el talón, como una pedrada, al correr, más la maniobra de Thompson alterada, es el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. El libro indica cirugía. El esguince de tobillo afecta los ligamentos laterales y no altera la maniobra de Thompson.

Pregunta de práctica

Mujer de 24 años se dobla el tobillo derecho hacia adentro jugando básquetbol hace 3 horas. Pudo caminar 4 pasos al llegar al SAPU. Al examen: leve aumento de volumen y dolor a la palpación del ligamento peroneoastragalino anterior, sin dolor en el borde posterior ni la punta de los maléolos, ni en la base del quinto metatarsiano ni en el navicular. Cajón anterior negativo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja antes de indicar tratamiento
B) Bota de yeso por 4 semanas
C) Reposo relativo, hielo, compresión y elevación, analgesia, carga precoz según tolerancia y ejercicios de propiocepción
D) Resonancia magnética para evaluar rotura ligamentosa
E) Derivación a traumatología para reparación quirúrgica

Respuesta C. Por las reglas de tobillo de Ottawa (camina 4 pasos, sin dolor óseo en maléolos, quinto metatarsiano ni navicular) no requiere radiografía. Es un esguince grado 1 del peroneoastragalino anterior, que se trata con medidas RICE, analgesia, movilización y carga precoz y rehabilitación propioceptiva; el yeso no está indicado.

Pregunta de práctica

Hombre de 29 años recibe un golpe en la cara externa de la rodilla derecha jugando fútbol hace 1 día. Camina con leve cojera. Al examen: dolor a la palpación del ligamento colateral medial, sin derrame articular. El bostezo en valgo a 30 grados de flexión es doloroso pero sin apertura de la interlínea y con tope firme. Lachman y cajón anterior negativos, sin bloqueo. **¿Cuál es el diagnóstico y el manejo más adecuados?**

A) Esguince grado 3 del colateral medial; cirugía de reparación
B) Esguince grado 1 del colateral medial; frío local, analgesia, carga según tolerancia y fortalecimiento precoz, sin inmovilización rígida
C) Rotura de menisco medial; resonancia magnética urgente
D) Rotura del ligamento cruzado anterior; derivar a cirugía artroscópica
E) Esguince grado 2; yeso inguinopédico por 6 semanas

Respuesta B. En el esguince grado 1 hay distensión de fibras sin pérdida de continuidad: dolor a la palpación y al estrés, pero sin laxitud y con tope firme. Se maneja con frío, analgesia, carga precoz y ejercicios, sin inmovilización rígida. La laxitud con tope firme sería grado 2 y sin tope, grado 3.

4.02.2.004 Fractura de cadera

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en adulto mayor con caída de propia altura, dolor inguinal e imposibilidad de apoyar; extremidad acortada y en rotación externa (posición impúdica).
- Estudio: radiografía de pelvis AP y cadera AP y axial (no resonancia ni radiografía de fémur como primer examen).

- Manejo inicial: analgesia, inmovilización, hidratación, prevención de úlceras por presión y TEV; tracción de partes blandas mientras espera cirugía si corresponde.
- Tratamiento siempre quirúrgico y precoz (24–48 h): prótesis en fractura de cuello femoral desplazada en mayor de 65 años; tornillos canulados si no desplazada o joven; tornillo dinámico en intertrocantérica.
- Diferencial: luxación posterior de cadera (joven, choque frontal, aducción y rotación interna, lesión del ciático) se reduce cerrada bajo anestesia.
- Mortalidad alta (hasta 50 % a 2 años): derivar a traumatología y tratar la osteoporosis subyacente tras la fractura.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 50

Una paciente de 80 años sufrió una caída a nivel, luego de la cual no pudo levantarse, presentando mucho dolor. Al examen físico presenta acortamiento de la extremidad inferior derecha, con ligera abducción y rotación externa, sin equimosis. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esguince de cadera
B) Fractura de cadera
C) Luxación posterior de cadera
D) Fractura de pelvis
E) Fractura vertebral con lesión del plexo lumbar

Respuesta B. Caída a nivel en una adulta mayor con impotencia funcional y extremidad acortada, en rotación externa y leve abducción: fractura de cadera clásica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 10

Una paciente de 26 años, sin antecedentes, mientras iba como copiloto sufre accidente de tránsito, resultando con dolor en extremidad inferior derecha. Al ingreso con vía aérea permeable, respiración espontánea, sin sangramientos evidentes, presión arterial de 150/90, Glasgow 15, extremidad inferior derecha en posición púdica. **El diagnóstico más probable es:**

A) Luxación anterior de cadera
B) Fractura intertrocantérica
C) Fractura de cuello femoral
D) Luxación posterior de cadera
E) Fractura de pelvis

Respuesta D. La posición púdica es característica de la luxación posterior. La fractura, en cambio, tiene posición impúdica: abducción, rotación externa y acortamiento.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 98

Un hombre protagoniza un accidente de tránsito, chocando de manera frontal, contra otro automóvil. Presenta intenso dolor en la cadera derecha, que le impide caminar. En su examen tiene una rotación fija hacia interno, con aducción del muslo. **El diagnóstico más probable es:**

A) Fractura de cuello femoral
B) Fractura de cotilo
C) Esguince grado 3 de cadera
D) Luxación anterior de cadera
E) Luxación posterior de cadera

Respuesta E. Aducción y rotación interna fija tras un choque frontal es la posición púdica de la luxación posterior de cadera. La fractura de cuello femoral tiene posición impúdica, con rotación externa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 178

Niño de 12 años, obeso, refiere dolor de 3 meses en cadera izquierda y claudicación progresiva, que actualmente impide la marcha. Al examen físico presenta dolor a la rotación interna y externa de la cadera izquierda. Se realiza radiografía AP pelvis y caderas, que se muestra a continuación: El diagnóstico es: **El diagnóstico es:**

A) Displasia del desarrollo de la cadera
B) Epifisiolisis
C) Fractura del cuello del fémur
D) Luxacion de la Cadera izquierda
E) Necrosis avascular de la cabeza del fémur

Respuesta B. Es una epifisiolisis de la cabeza femoral clásica: un adolescente con claudicación y dolor de cadera, asociada a sobrepeso y obesidad. Además se ve el signo del helado caído.

Pregunta de práctica

Un paciente de 72 años, que camina sin ayuda, tiene una fractura de cuello femoral desplazada. **¿Cuál es el tratamiento?**

A) DHS o tornillo dinámico de cadera
B) Prótesis de cadera
C) Tornillo canulado y observar si hace necrosis
D) Cirugía de Girdlestone
E) Inmovilización y manejo conservador por la edad

Respuesta B. Fractura de cuello femoral, desplazada y en mayor de 65 años: las tres condiciones para indicar prótesis de entrada, por el alto riesgo de necrosis avascular. El tornillo dinámico es para fracturas intertrocantéricas, el Girdlestone para postrados, y la fractura de cadera siempre se opera.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 26 años, sufre un accidente automovilístico de alta energía, como conductor. Llega a la urgencia entablillado y con hemodinamia estable. Destaca la extremidad inferior derecha en flexión y aducción, dolorosa, con imposibilidad de caminar. Se realiza radiografía anteroposterior de pelvis, que se muestra a continuación (fuente: radiopaedia): ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura de la cabeza femoral derecha
B) Fractura de zona posterior del cotilo derecho
C) Luxofractura posterior de cadera derecha
D) Fractura de pelvis inestable
E) Fractura extracapsular de cadera derecha

Respuesta C. Está en posición púdica, clásica de la luxación posterior de cadera; y la radiografía muestra la luxación posterior derecha. No queda claro el rasgo de fractura.

4.02.2.005 Fractura de la muñeca

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Fractura de radio distal (Colles): adulto mayor que cae sobre la mano en extensión; deformidad en dorso de tenedor, equimosis y dolor a la compresión del radio distal; típica de hueso osteoporótico.
- En niños con fisis abierta el equivalente es la disyunción del radio distal. Fractura de escafoides: dolor en la tabaquera anatómica sin deformidad; la radiografía inicial puede ser normal.
- Confirmación: radiografía de muñeca AP y lateral (proyecciones de escafoides si se sospecha).
- Manejo inicial: examen neurovascular (nervio mediano), analgesia, valva de yeso antebraquiopalmar no circular, elevación y movilización de dedos.
- Sospecha de escafoides con radiografía normal: inmovilizar igual y repetir imagen en 10–14 días (riesgo de necrosis avascular y pseudoartrosis).
- Vigilar síndrome compartimental (dolor desproporcionado bajo el yeso: retirarlo). Seguimiento: derivar a traumatología; tratar la osteoporosis.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 141

Paciente de 70 años sufre una caída a nivel, con apoyo de la extremidad superior en extensión contra el suelo. Evoluciona con dolor en la muñeca que le impide moverla. Consulta al día siguiente con la muñeca deformada en "dorso de tenedor", equimosis palmar y dorsal, y dolor a la compresión del radio distal. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esguince de muñeca
B) Fractura de la epífisis distal del radio
C) Disyunción del extremo distal del radio
D) Luxofractura de Monteggia
E) Fractura de escafoides carpiano

Respuesta B. Adulto mayor que cae sobre la mano en extensión y presenta deformidad en dorso de tenedor tiene una fractura de radio distal con desplazamiento dorsal (Colles), típica de hueso osteoporótico. La disyunción ocurre en niños con fisis abierta; el escafoides duele en la tabaquera anatómica sin esta deformidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 65 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 65 años sufre caída a nivel, apoyando la mano derecha contra el suelo, en extensión de la extremidad. Evoluciona con dolor intenso en la muñeca, que le impide realizar movimientos. Al examen físico se aprecia deformidad de la muñeca y dolor epicrítico a la presión del radio distal. El diagnóstico más probable es:

A) Fractura de escafoides
B) Fractura de epifisis distal del radio
C) Disyunción-fractura de radio distal
D) Luxofractura de Monteggia
E) Luxación de cúpula radial

Respuesta B. Es una mala pregunta: no hay duda de que es una fractura de radio distal, pero la clínica es insuficiente para distinguir entre la fractura de epífisis y la disyunción fractura. Sin embargo, “disyunción fractura” o “luxofractura” se usa más para las fracturas de Monteggia y Galeazzi, que no corresponden a este cuadro, por lo que dejaremos la B como correcta. Sin embargo, la fractura no necesariame

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 99 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años sufre una caída a nivel, cayendo sobre la mano izquierda, con extremidad superior izquierda en extensión. Al examen físico presenta dolor a la compresión axial del pulgar y al presionar la tabaquera anatómica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fractura de la base de la primera falange proximal
B) Fractura de escafoides
C) Fractura perilunar
D) Fractura del extremo distal del radio
E) Esguince de la primera articulación metacarpofalángica

Respuesta B. Diagnóstico: Fractura de escafoides (opción B). Es un fractura de escafoides clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

4.02.2.006 Fractura inestable de la pelvis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar en politraumatizado por mecanismo de alta energía con dolor pélvico, inestabilidad y shock; la fractura en libro abierto (sínfisis) sangra por plexos venosos y es causa principal de muerte precoz.
- Radiografía de pelvis AP en la evaluación primaria; no repetir maniobras de estabilidad (rompen coágulos).
- Manejo inicial: ABCDE, dos vías gruesas, volumen y transfusión; cerrar la pelvis con sábana pélvica sobre los trocánteres mayores o faja pélvica; no perder tiempo en imágenes si hay shock.
- Lesión uretral: sangre en el meato, próstata flotante, hematoma perineal → prohibida la sonda Foley; uretrocistografía retrógrada y cistostomía suprapúbica.
- Tacto rectal y vaginal para descartar fractura expuesta a mucosa (antibióticos y cirugía urgente).
- Seguimiento: derivar de urgencia a centro con traumatología (fijación externa, angioembolización).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 26

Paciente de 30 años sufre una caída desde 15 metros de altura, golpeándose contra el suelo. Al examen físico está orientado, con frecuencia cardíaca de 80 y presión arterial de 120/80, con mucho dolor a la compresión de la pelvis, mayor a izquierda. Se solicita una radiografía de pelvis que muestra una fractura pélvica. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Pasar una sonda Foley
B) Indicar reposo con una hamaca o sábana pélvica
C) Administrar antibióticos
D) Realizar cirugía de inmediato
E) Solicitar ecografía de abdomen y pelvis

Respuesta B. Frente a una fractura de pelvis, lo primero es estabilizar el anillo pélvico externamente, con un tutor externo o, si no está disponible, una sábana o hamaca pélvica, para limitar la hemorragia venosa. La sonda Foley se pospone hasta descartar una lesión uretral asociada.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 51

Un paciente de 28 años sufre un accidente de tránsito de alta intensidad, por lo que es trasladado al servicio de urgencia. En la evaluación inicial tiene presión arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardíaca 115x' y se aprecia adolorido. Al examen, además, tiene dolor intenso al comprimir la zona iliaca y púbica y al realizar movimientos de rotación de la pelvis. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Instalar sonda Foley
B) Realizar laparotomía exploradora
C) Realizar radiografía AP de pelvis
D) Instalar sábana pélvica
E) Solicitar TAC de pelvis

Respuesta D. Tiene una probable fractura de pelvis, pero por tener compromiso hemodinámico, lo más urgente es poner una vía venosa, administrar fluidos y estabilizar la pelvis (por ejemplo con una sábana pélvica).

Pregunta de práctica

Un paciente de 30 años, hemodinámicamente estable, ingresa tras un accidente de tránsito con una fractura de pelvis confirmada por radiografía. Al hacer el tacto rectal, el dedo sale con sangre y se palpa un fragmento óseo que protruye a la luz del recto. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Manejo ortopédico con reposo en cama
B) Antibióticos y cirugía de urgencia
C) Instalar una sonda Foley
D) Observación y repetir el tacto rectal en 24 horas
E) Solo analgesia y control en el policlínico

Respuesta B. El tacto rectal y vaginal busca una fractura expuesta hacia la mucosa. Si la fractura comunica con el recto, es una fractura expuesta de la pelvis y requiere antibióticos y cirugía de urgencia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Mujer con fractura de pelvis inestable con shock: conducta de reanimación inicial:

A) SF 0,9% yo puse esto u.u
B) Cerrar anillo pélvico (pienso que es esta porque es lo único que disminuirá el sangrado que le está matando) Pero preguntaban por manejo del shock inicial
C) Tratamientos específicos de la causa
D) Reparación arterial
E) Amoxicilina

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: SF 0,9% yo puse esto u.u (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.02.2.007 Fracturas de diáfisis y metáfisis

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización · Tema 12.6 Retardo de Consolidación, Pseudoartrosis & Consolidación Viciosa · Tema 12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Clínica de fractura: dolor intenso que aumenta al movilizar, deformidad, impotencia funcional, crepitación y equimosis.
- Confirmación: radiografía en dos proyecciones (AP y lateral) que incluya articulaciones proximal y distal; TAC si hay rasgo articular.
- Asociaciones: diáfisis humeral → nervio radial (mano caída); supracondílea de húmero → mediano y arteria braquial; diáfisis de tibia → síndrome compartimental; fémur → shock hipovolémico.
- Manejo inicial: ABC primero, examen neurovascular antes y después, alinear con tracción suave, inmovilizar con férula o valva no circular que incluya articulaciones vecinas y analgesia.
- Indicación quirúrgica: fémur y tibia diafisarias, desplazadas o irreductibles, conminutas, segmentarias, intraarticulares, expuestas o inestables.
- Seguimiento: derivar a traumatología; vigilar retardo de consolidación, pseudoartrosis (movilidad indolora del foco) y consolidación viciosa.

PREGUNTAS (8)

Pregunta de práctica

Un hombre de 30 años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**

A) Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas
B) Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral
C) Luxación de codo; TAC de antebrazo
D) Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior
E) Contusión grave; solo analgesia y observación

Respuesta B. Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. Se confirma con radiografías en dos proyecciones, anteroposterior y lateral. Una sola proyección no basta.

Pregunta de práctica

Un paciente con fractura de tibia en yeso desde hace cuatro meses sigue con dolor leve en el foco de fractura. La radiografía muestra callo óseo en formación pero sin terminar de consolidar. **¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?**

A) Pseudoartrosis; cirugía para remover partes blandas
B) Retraso de consolidación; mejorar la inmovilización
C) Consolidación viciosa; cirugía de refractura
D) Pseudoartrosis atrófica; tratamiento de la mala irrigación
E) Osteomielitis; antibióticos endovenosos

Respuesta B. El retraso de consolidación se presenta con dolor persistente más allá del tiempo normal y callo en maduración en la radiografía. El tratamiento es mejorar la inmovilización, que era la causa. La pseudoartrosis tiene movilidad anormal y poco dolor.

Pregunta de práctica

Un hombre de 28 años es atropellado. Llega con dolor intenso y deformidad del muslo derecho. Presión arterial 82/50 mmHg, frecuencia cardíaca 128 por minuto, piel fría y sudorosa. Está consciente, con vía aérea permeable. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Radiografías de fémur AP y lateral antes de cualquier otra medida
B) Cirugía inmediata de osteosíntesis sin otra evaluación
C) Manejo ABC con reposición de volumen e inmovilización provisoria
D) Yeso circular e indicar control ambulatorio
E) Analgesia oral y observación

Respuesta C. Un fémur puede perder hasta 1,5 litros de sangre, y este paciente está en shock hipovolémico. Primero va el ABC: reposición de volumen y control de la hemorragia, con inmovilización provisoria. La radiografía y la cirugía vienen después de estabilizarlo.

Pregunta de práctica

Un paciente tiene una fractura de pierna con el hueso muy desplazado, irreductible por maniobra ortopédica, y con múltiples fragmentos conminutos. **¿Cuál es la conducta?**

A) Inmovilización con yeso e indicar control en dos semanas
B) Cirugía con reducción y osteosíntesis
C) Tracción continua por cuatro semanas y luego yeso
D) Observación porque las fracturas de pierna siempre consolidan solas
E) Inmovilización con órtesis funcional por seis semanas

Respuesta B. Una fractura muy desplazada, irreductible y conminuta tiene indicación quirúrgica clara: reducción y osteosíntesis. Con yeso solo hay alto riesgo de pseudoartrosis y consolidación viciosa.

Pregunta de práctica

Un hombre de 55 años, fumador y diabético, tuvo una fractura de tibia manejada con yeso hace 8 meses. Consulta porque nota que "se mueve" el sitio de la fractura, casi sin dolor. La radiografía muestra los extremos óseos adelgazados, redondeados, en punta de lápiz. **¿Cuál es el diagnóstico y la causa más probable?**

A) Retardo de consolidación; inmovilización inadecuada
B) Pseudoartrosis hipertrófica; mala inmovilización
C) Pseudoartrosis atrófica; mala irrigación
D) Consolidación viciosa; mala reducción inicial
E) Consolidación normal; no requiere estudio

Respuesta C. La movilidad anormal casi sin dolor orienta a pseudoartrosis. Los extremos adelgazados en punta de lápiz corresponden a la forma atrófica, por mala irrigación sanguínea, y el tabaquismo y la diabetes la favorecen. La hipertrófica se ve con extremos ensanchados en pata de elefante.

Pregunta de práctica

Un hombre de 32 años sufre un accidente de moto y llega con dolor intenso en el muslo derecho, deformidad del eje de la extremidad y crepitación. No puede mover la pierna. Los pulsos distales están presentes. **¿Cuál es el estudio y el tratamiento más adecuados?**

A) Radiografía de fémur AP y lateral con cadera y rodilla; cirugía con clavo intramedular
B) Radiografía solo de la zona del dolor; yeso por seis semanas
C) Resonancia magnética de muslo; reposo y analgesia
D) Solo radiografía de pelvis; manejo ortopédico
E) Ecografía de partes blandas; vendaje compresivo

Respuesta A. La fractura de fémur se confirma con radiografía AP y lateral que incluya las articulaciones proximal y distal, y su tratamiento es siempre quirúrgico, habitualmente con clavo intramedular o placa. El manejo ortopédico no vence la fuerza muscular y termina en consolidación viciosa o pseudoartrosis.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente sufre una caída a nivel, con golpe en el hombro derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se realizan radiografías de hombro, una de las que se muestra a continuación: FOTO (Radiografía AP de hombro, con fractura del tercio medio de la clavícula derecha, con ligero desplazamiento, sin conminución) ¿Qué tipo de inmovilización es la más adecuada?

A) Vendaje axial de hombro
B) Vendaje en ocho
C) Yeso Velpeau
D) Yeso toracobraquial
E) Cabestrillo

Respuesta E. , ¿B?. El cabestrillo y el vendaje en 8 son los más usados en las fracturas del tercio medio de clavícula. Sin embargo, también se pueden usar otros tipos de inmovilización, según la valoración por el especialista. El vendaje en 8 se asocia a mayores molestias, por compresión cutánea y del complejo neurovascular axilar, así que el cabestrillo suele ser lo más recomendado. De todos, modos, es una p

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 133 · texto original del banco, sin revisar

Caída en paracaídas, se observa deformidad en valgo: a. Fractura platillo tibial lateral (esta, confirmado por un TMT)

B) Fractura cóndilo medial fémur
C) Rotura menisco anterior
D) Ligamento cruzado anterior
D) Laparotomía exploratoria
E) Cirugía laparoscópica

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Fractura cóndilo medial fémur, Rotura menisco anterior) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

4.02.2.008 Fracturas expuestas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Toda herida cercana a una fractura es expuesta hasta demostrar lo contrario; riesgo principal: infección y osteomielitis.
- Gustilo-Anderson: I herida <1 cm; II 1–10 cm; III >10 cm o alta energía (IIIA cobertura adecuada, IIIB requiere colgajo, IIIC lesión arterial). Arma de fuego siempre grado III.
- Manejo inicial: ABC, lavado abundante con suero fisiológico, antibiótico EV en la primera hora, analgesia y profilaxis antitetánica según esquema.
- Antibiótico: grado I cefazolina; II cefazolina + gentamicina; III cefazolina + gentamicina + clindamicina (cobertura de anaerobios).
- Antes del traslado: no suturar, cubrir con apósito estéril, valva de yeso larga y abierta (no yeso circular), revisar pulsos y nervios antes y después.
- Seguimiento: derivar de urgencia para aseo quirúrgico, desbridamiento y fijación (externa frecuente en grado III).

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un paciente tiene fractura de pierna expuesta grado 1 de Gustilo: herida menor de un centímetro, baja energía, contaminación mínima. **¿Cuál es el antibiótico endovenoso inicial?**

A) Cefazolina
B) Amikacina más cefazolina
C) Cefazolina más amikacina más clindamicina
D) Metronidazol intravenoso
E) Amoxicilina clavulánico oral

Respuesta A. El grado I requiere cobertura para gram positivos, especialmente estafilococo aureus, y la cefazolina es la cefalosporina de primera línea. La amikacina se agrega en el grado II, y la triple combinación es del grado III. En la fractura expuesta el tratamiento es endovenoso.

Pregunta de práctica

Un hombre de 34 años recibe un disparo en la pierna izquierda. Hay un orificio de 1 cm en la cara anterior de la tibia, sin hueso visible, y la radiografía muestra una fractura diafisaria. Tiene pulsos distales presentes y está hemodinámicamente estable. **¿Cómo se clasifica y qué esquema antibiótico corresponde?**

A) Grado I; cefazolina sola
B) Grado II; cefazolina más gentamicina
C) Grado III; cefazolina, gentamicina y clindamicina
D) No es fractura expuesta; yeso circular y control
E) Grado III; solo metronidazol

Respuesta C. Toda fractura por arma de fuego se clasifica automáticamente como grado III, aunque la herida sea pequeña. Corresponde triple cobertura: cefazolina, gentamicina y clindamicina, además del aseo y el traslado con valva abierta.

4.02.2.009 Heridas de la mano no complicadas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 11.18 Manejo de Heridas Traumáticas, Mordeduras Animales/Humanas & Profilaxis Antitetánica

QUÉ HAY QUE SABER

- Explorar siempre la función de tendones flexores y extensores de cada dedo contra resistencia, la sensibilidad de los pulpejos (discriminación de 2 puntos) y la perfusión (llene capilar).
- Herida no complicada: limpia, reciente, sin compromiso de tendones, nervios digitales, vasos ni articulación ni cuerpo extraño; se maneja en urgencia.
- Tratamiento: aseo, exploración bajo anestesia local, hemostasia por compresión y sutura con puntos simples de nylon; no requiere antibiótico.
- Profilaxis antitetánica: herida limpia con esquema completo solo si última dosis >10 años; sucia si >5 años; esquema incompleto o desconocido con herida sucia: vacuna + inmunoglobulina.
- Mordeduras de la mano: lavado a presión, no suturar, amoxicilina/clavulánico; evaluar profilaxis antirrábica.
- Seguimiento completo: control de la herida a las 48–72 h y retiro de puntos a los 10–14 días; derivar si aparece déficit tendinoso o nervioso.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 30 años se corta la palma de la mano con un cuchillo de cocina hace 2 horas. Herida lineal limpia de 2 cm en la eminencia tenar, sangrado controlado con compresión. La flexión y extensión de todos los dedos contra resistencia es normal, la sensibilidad de los pulpejos (discriminación de 2 puntos) está conservada y el llene capilar es normal. Vacuna antitetánica completa hace 4 años. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Vacuna antitetánica y gammaglobulina antitetánica
B) Derivar a cirugía de mano para exploración en pabellón
C) Dejar la herida abierta para cierre por segunda intención
D) Cierre con puntos y cefazolina oral por 7 días
E) Aseo, exploración bajo anestesia local y sutura con puntos simples de nylon

Respuesta E. Una herida limpia de la mano, reciente, con tendones, nervios digitales y perfusión indemnes es una herida no complicada: se maneja en urgencia con aseo, exploración bajo anestesia local y sutura. No requiere antibióticos. Con vacuna completa hace menos de 5 años no necesita refuerzo antitetánico.

4.02.2.010 Lesiones de los nervios periféricos

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Diagnóstico clínico: déficit motor y sensitivo distal tras fractura o luxación; examinar antes y después de reducir o inmovilizar.
- Radial: fractura de diáfisis humeral, no extiende muñeca ni dedos, hipoestesia posterior. Axilar: luxación anterior de hombro, no abduce, pierde sensibilidad en parche deltoideo.
- Mediano: supracondílea de húmero, no flecta dedos 1–3. Cubital: fractura medial de codo, no flecta dedos 4 y 5. Ciático: luxación posterior de cadera, no flecta rodilla ni dorsiflexiona.
- Compresiones sin fractura: parálisis del sábado (radial), luna de miel (plexo braquial); peroneo común en la cabeza del peroné por yesos o tracción.
- Déficit parcial (neuroapraxia): observar, suele recuperarse. Déficit total o tras herida penetrante: exploración quirúrgica.
- Manejo inicial: inmovilizar, analgesia y derivar a traumatología.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 103

Un paciente sufre una fractura de húmero derecho, que es manejada mediante reducción quirúrgica y osteosíntesis. Al quinto día, evoluciona con parestesias y dolor de la extremidad, asociada a imposibilidad de extender la muñeca. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Síndrome compartimental
B) Compresión del nervio mediano
C) Lesión del nervio musculocutáneo
D) Atrapamiento del nervio cubital
E) Lesión del nervio radial

Respuesta E. Es la afectación clásica del nervio radial, que está en estrecho contacto con la diáfisis humeral. No poder extender la muñeca es la clave.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 173

Una paciente sufre una fractura de la diáfisis humeral derecha, la que es manejada mediante cirugía, con osteosíntesis con placa. A las 24 horas, evoluciona con dolor en el sitio de la fractura, asociada a imposibilidad de extender la muñeca derecha. Mantiene la flexión activa de los dedos de esa mano. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trombosis de la arteria braquial
B) Neurapraxia del nervio radial
C) Desplazamiento de la placa
D) Síndrome compartimental
E) Lesión del plexo braquial

Respuesta B. El dolor en la zona orienta a un síndrome compartimental, pero solo se describe la afectación del nervio radial, sin otras alteraciones, por lo que lo más probable es una neurapraxia del radial.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 70

Paciente de 35 años sufre traumatismo en la región posterior del húmero. Al examen: no puede extender la muñeca ni los dedos (caída de muñeca). ¿Qué nervio fue lesionado? **¿Qué nervio fue lesionado?**

A) Nervio radial (en canal de torsión)
B) Nervio cubital
C) Nervio mediano
D) Nervio musculocutáneo
E) Nervio axilar

Respuesta A. Fractura de húmero con caída de muñeca es una lesión del nervio radial en el canal de torsión, o surco espiral. Inerva los extensores de la muñeca y de los dedos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 41

Una paciente de 35 años, sin antecedentes, sufre fractura de diáfisis humeral izquierda, evolucionando posteriormente con hipostesia del dorso de dicha mano, asociado a imposibilidad de realizar extensión de muñeca y falanges. ¿La estructura más probablemente dañada en este caso es? **¿La estructura más probablemente dañada en este caso es?**

A) Nervio mediano
B) Nervio ulnar
C) Nervio radial
D) Nervio axilar
E) Nervio musculocutáneo

Respuesta C. Fractura de la diáfisis humeral con hipoestesia del dorso de la mano e imposibilidad de extender la muñeca y las falanges corresponde al nervio radial. Es una pregunta clásica de libro.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 43 años consulta por dolor y parestesias en el dedo meñique y anular derechos, que inició hace 3 años y ha progresado, aumentando su intensidad. Relata que, en la noche, los síntomas suelen ser más intensos y que actualmente tiene parestesias continuas en el meñique. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Síndrome del túnel carpiano
B) Contractura de Dupuytren
C) Radiculopatía C7
D) Atrapamiento cubital
E) Compresión del plexo braquial

Respuesta D. Diagnóstico: Atrapamiento cubital (opción D). Es un atrapamiento cubital clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

`4.02.2.011` Lesiones de partes blandas (contusiones, hematomas, desgarros)

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 12.8 Lesiones de Rodilla: Meniscos, Ligamentos Cruzados y Colaterales & Dolor Patelofemoral · Tema 12.9 Lesiones de Partes Blandas: Contusiones, Hematomas, Esguinces & Rotura del Aquiles

QUÉ HAY QUE SABER

- Contusión: golpe directo sin herida; dolor, edema y equimosis sin signos de fractura; radiografía si hay alta energía o dolor muy invalidante.
- Tratamiento de contusión: AINE, frío local las primeras 48 h y luego calor, reposo relativo; pronóstico excelente.
- Hematoma: colección fluctuante, violácea; ecografía de apoyo. Conservador con frío, calor y AINE; drenaje quirúrgico si es muy grande, muy doloroso o infectado (calor, rubor, fiebre).
- Desgarro muscular: dolor súbito durante esfuerzo; RICE, AINE y rehabilitación progresiva.
- Rotura del tendón de Aquiles: «pedrada» en el talón al correr en adulto de mediana edad, Thompson alterado → derivar, no es esguince. Quiste de Baker roto simula TVP (antecedente de masa poplítea).
- Seguimiento completo: control clínico; reevaluar con radiografía o ecografía si no mejora.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 162

Futbolista de 22 años que sufre giro brusco con la rodilla semiflexionada. Presenta edema articular rápido (hemartros), signo del cajón anterior positivo y prueba de Lachman positiva. **¿Qué estructura se lesionó?**

A) Ligamento cruzado anterior (LCA)
B) Ligamento cruzado posterior (LCP)
C) Ligamento colateral medial (LCM)
D) Menisco medial
E) Ligamento patelofemoral

Respuesta A. Cajón anterior (+) + Lachman (+) + hemartros post trauma en valgus/rotación = ruptura del ligamento cruzado anterior (LCA). Es la lesión ligamentaria más frecuente en deportistas jóvenes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 8

Un paciente de 65 años sufre una caída a nivel, con golpe en la rodilla derecha. Evoluciona con dolor e impotencia funcional. Se observa depresión suprarrotuliana en dicha rodilla y se solicita una radiografía de rodilla derecha, que no evidencia rasgos de fractura. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Luxación de rótula
B) Disfunción patelo-femoral
C) Rotura del ligamento cruzado anterior
D) Rotura del ligamento rotuliano
E) Rotura del ligamento del cuádriceps

Respuesta E. Solo por la anatomía es posible adivinar la respuesta. El ligamento del cuádriceps está sobre la rótula. El tendón rotuliano está debajo de la rótula y se inserta en la tuberosidad tibial.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 141

Una paciente de 65 años, con IMC: 34, consulta por dolor progresivo, de una semana de evolución, en la cara lateral de la cadera, que aumenta con la caminata y limita sus movimientos. Además, en el último tiempo, el dolor le impide dormir para ese lado. Al examen físico tiene dolor a la palpación de la cara externa de la cadera y a la rotación externa forzada. **El diagnóstico más probable es:**

A) Coxartrosis
B) Fractura incompleta de cadera por estrés
C) Hernia del núcleo pulposo, con radiculopatía L2
D) Bursitis trocantérica
E) Síndrome de la fascia lata rígida

Respuesta D. Dolor lateral de la cadera, que empeora al caminar y al dormir sobre ese lado, con dolor a la palpación de la cara externa, en una paciente obesa, es una bursitis trocantérica.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 159

Paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera, claudicación y dolor a la palpación lateral con limitación a la rotación interna. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Coxartrosis (artrosis de cadera)
B) Síndrome de la banda iliotibial
C) Tendinopatía del glúteo medio
D) Bursitis trocantérica
E) Fractura de estrés del cuello femoral

Respuesta D. Un paciente obeso con dolor en la cara externa de la cadera y dolor a la palpación lateral tiene una bursitis trocantérica.

Pregunta de práctica

Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. **¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?**

A) Lesión del menisco externo; radiografía de rodilla
B) Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear
C) Rotura del ligamento cruzado anterior; resonancia magnética
D) Lesión del menisco interno; radiografía de rodilla en dos proyecciones
E) Disfunción patelofemoral; solo reposo y AINEs

Respuesta B. Con la maniobra de Apley, si duele a la rotación externa está lesionado el menisco interno. El bloqueo articular es característico de lesión meniscal, y el diagnóstico se confirma con resonancia magnética, porque la radiografía no ve los meniscos.

Pregunta de práctica

Un deportista de cuarenta años va corriendo y siente súbitamente como una pedrada intensa en el talón. No puede caminar. La maniobra de Thompson está alterada. **¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?**

A) Esguince de tobillo grado tres; inmovilización con bota removible
B) Rotura del tendón de Aquiles; cirugía urgente
C) Rotura del tendón de Aquiles; inmovilización con yeso
D) Fractura de calcáneo; radiografía de pie
E) Desgarro muscular de gemelos; RICE y AINEs

Respuesta B. El dolor súbito en el talón, como una pedrada, al correr, más la maniobra de Thompson alterada, es el cuadro clásico de rotura del tendón de Aquiles. El libro indica cirugía. El esguince de tobillo afecta los ligamentos laterales y no altera la maniobra de Thompson.

Pregunta de práctica

Un hombre de 35 años sufrió una patada en el muslo hace cuatro días jugando fútbol. Consulta por aumento de volumen fluctuante, muy doloroso, con la piel enrojecida y caliente, y fiebre de 38,5 °C. La radiografía de fémur no muestra fractura y la ecografía muestra una colección líquida organizada. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Frío local y antiinflamatorios, con control en una semana
B) Drenaje quirúrgico del hematoma
C) Calor local y reposo absoluto
D) Inmovilización con yeso por tres semanas
E) Solo analgesia y alta, porque es una contusión

Respuesta B. Un hematoma se maneja de forma conservadora, pero está indicado el drenaje quirúrgico cuando es muy grande, muy doloroso o con signos de infección secundaria (calor, rubor, fiebre). Aquí hay una colección organizada con signos de infección.

4.02.2.012 Luxación del hombro

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Luxación anterior (la más frecuente): trauma con brazo en abducción y rotación externa; hombro en charretera, brazo en abducción y rotación externa, impotencia funcional.
- Radiografía AP y axial o lateral antes de reducir para descartar fractura asociada (troquíter, cuello humeral).
- Evaluar y registrar antes y después de la reducción el nervio axilar (sensibilidad del parche deltoideo) y los pulsos distales.
- Reducción cerrada precoz con analgesia/sedación (tracción-contratracción, Kocher u otras); radiografía de control y nuevo examen neurovascular.
- Inmovilización con cabestrillo por 2–3 semanas y luego kinesioterapia; luxación posterior sospecharla en convulsiones o electrocución.
- Seguimiento: derivar a traumatología, sobre todo en jóvenes por alto riesgo de recidiva e inestabilidad.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 35

Un paciente de 23 años sufre una caída jugando fútbol, cayendo con el hombro derecho contra el piso, con una luxación anterior de hombro derecho confirmada con radiografías, que descartan fracturas. **¿Qué evaluación debe realizarse obligatoriamente en el examen físico antes de proceder con las maniobras de reducción?**

A) Buscar presencia de equimosis
B) Buscar deformación en "charretera"
C) Explorar la sensibilidad de la zona deltoidea
D) Evaluar la impotencia funcional
E) Evaluar crépito óseo

Respuesta C. La luxación anterior se asocia a lesión del nervio axilar, que da la sensibilidad de la zona deltoidea. Se debe registrar su estado antes de reducir, para que no se atribuya después a la maniobra. Las demás opciones ya se evaluaron con la clínica y la radiografía.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 35

Paciente de 23 años sufre una caída mientras jugaba fútbol, cayendo con el hombro derecho contra el piso, con una luxación anterior de hombro derecho confirmada por radiografías que descartan fracturas. **¿Qué evaluación debe realizarse obligatoriamente en el examen físico antes de proceder con las maniobras de reducción?**

A) Buscar presencia de equimosis
B) Buscar deformación en "charretera"
C) Explorar la sensibilidad de la zona deltoidea
D) Evaluar la impotencia funcional
E) Evaluar crépito óseo

Respuesta C. El nervio axilar es el más lesionado en la luxación anterior de hombro. Antes y después de reducir se debe documentar la sensibilidad de la cara lateral del hombro (zona del parche deltoideo) y los pulsos distales. La charretera e impotencia funcional confirman la luxación, pero no cambian la conducta.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 27 años sufre una caída a nivel, con golpe del hombro, contra el piso. Evoluciona con intenso dolor e impotencia funcional, por lo que se solicitan radiografías de hombro, que. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Reducción cruenta en una semana
B) Inmovilización por 10 días con yeso
C) Artroscopía para reparación del labrum
D) Inmovilización por 7 días con cabestrillo bloqueado
E) Reducción ortopédica de inmediato

Respuesta E. La luxación anterior de hombro se reduce ortopédicamente, de inmediato. Si recurre, se trata con cirugía.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 10 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 24 años, sufre una caída a nivel, mientras jugaba básquetbol, cayendo con el hombro izquierdo, contra el suelo. Presenta impotencia funcional y al examen físico destaca dolor a la movilización del hombro izquierdo. Se solicita una radiografía AP de hombro y axial de escápula, que se muestran a continuación: El diagnóstico más probable es:

A) Luxación anterior de hombro
B) Fractura de escápula
C) Luxación acromioclavicular
D) Fractura de clavícula
E) Lesión del tendón del manguito rotador

Respuesta C. En la imagen se veía la disyunción acromioclavicular o luxación acromioclavicular, con leve desplazamiento hacia superior del extremo distal de la clavícula. La sola clínica, en este caso, no permite diferenciarlo. Sin embargo, es característico de la luxación anterior de hombro el signo de la charretera y, de la disyunción, el signo de la tecla de piano.

4.02.2.013 Luxofractura del tobillo

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar ante torcedura de tobillo con deformidad, dolor óseo en maléolos, equimosis inmediata y extensa e imposibilidad de apoyar.
- Radiografía de tobillo AP, lateral y mortaja antes de cualquier tratamiento; buscar fractura bimaleolar, sindesmosis inestable y fractura de Maisonneuve (cabeza del peroné).
- Manejo inicial: analgesia, reducción cerrada bajo sedación si hay luxación (sobre todo con compromiso cutáneo o vascular) e inmovilización transitoria con valva de yeso abierta.
- Examen neurovascular (pulsos, llene capilar, sensibilidad) antes y después de reducir; elevación de la extremidad.
- No tratar como esguince con bota removible; evitar yeso circular por riesgo de síndrome compartimental.
- Seguimiento: derivar a traumatología para reducción y osteosíntesis.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 138

Un paciente de 21 años sufre accidente en esquí con caída y torsión del tobillo derecho, evolucionando con dolor e impotencia funcional. Se solicita radiografía de tobillo que muestra una luxofractura. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Reposo con extremidad en elevación
B) Reducción cerrada e inmovilización con valva de yeso
C) Analgésicos y apoyo progresivo con mínima carga
D) Vendaje compresivo
E) Tracción e inmovilización con yeso de la extremidad

Respuesta B. Es una luxofractura de tobillo, de manejo quirúrgico. Mientras tanto, el manejo inicial es analgesia, reducción cerrada e inmovilización transitoria con valva de yeso abierta, para evitar un síndrome compartimental. Aplica a otras fracturas desplazadas que esperan cirugía.

Pregunta de práctica

Un paciente con fractura de tobillo confirmada en la radiografía. **¿Cuál es el tratamiento?**

A) RICE más bota removible por cuatro semanas
B) Yeso de pierna por seis semanas
C) Cirugía con reducción y osteosíntesis
D) Observación ambulatoria y control en una semana
E) Inmovilización con bota de yeso y evaluar en dos semanas

Respuesta C. Las fracturas de fémur, pierna y tobillo se tratan quirúrgicamente por regla general. La cirugía permite reducir y fijar bien, y que el paciente apoye antes. El RICE con bota es el manejo del esguince; la inmovilización solo es parte del manejo mientras llega la cirugía.

4.02.2.014 Politraumatizado

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Politraumatizado: lesión de al menos dos o tres sistemas; en Chile la principal causa son los accidentes de tránsito. La lesión más llamativa no siempre es la más letal.
- Evaluación primaria ABCDE en orden: A vía aérea con control cervical (Glasgow ≤8: intubación); B ventilación (descomprimir neumotórax a tensión sin esperar radiografía); C hemorragia (compresión, dos vías gruesas, ácido tranexámico antes de 3 h, suero ≤1 L y hemoderivados); D Glasgow y pupilas; E exposición y evitar hipotermia.
- Radiografías iniciales: columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP en todo politraumatizado; eco-FAST para hemoperitoneo.
- Nunca sonda Foley con uretrorragia (cistostomía); sonda orogástrica, no nasogástrica, si hay fractura de base de cráneo.
- Tríada letal (hipotermia, acidosis, coagulopatía): cirugía de control de daños. Evaluación secundaria (AMPLIA) solo cuando está estable.
- Seguimiento: estabilizar y derivar a centro de trauma.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 134

Un niño de 8 años sufre un atropello mientras cruzaba la calle, resultando con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% a aire ambiental. Sus signos vitales muestran taquicardia a 150 latidos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Además, se observan múltiples equimosis y, en el examen pulmonar se ausculta asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo pulmonar izquierdo. **¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?**

A) Realizar intubación orotraqueal
B) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C) Puncionar el espacio pleural izquierdo
D) Solicitar radiografía de tórax
E) Solicitar TAC de tórax

Respuesta C. Trauma, shock, desaturación y murmullo abolido en un hemitórax: neumotórax a tensión hasta demostrar lo contrario. Se descomprime de inmediato (punción o toracostomía), antes que la vía aérea con presión positiva y sin esperar imágenes.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 134

Un niño de 8 años es atropellado mientras cruzaba la calle, con golpe en la espalda y las extremidades. Ingresa con marcada disnea, saturando 85% con aire ambiental, taquicardia de 150 latidos por minuto y presión arterial 70/40 mmHg. Se observan múltiples equimosis y, en el examen pulmonar, asimetría del murmullo pulmonar, con abolición del murmullo izquierdo. **¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?**

A) Realizar intubación orotraqueal
B) Administrar oxígeno por mascarilla de recirculación
C) Puncionar el espacio pleural izquierdo
D) Solicitar radiografía de tórax
E) Solicitar TAC de tórax

Respuesta C. Politraumatizado con insuficiencia respiratoria, shock y abolición del murmullo unilateral: neumotórax a tensión, diagnóstico clínico que se resuelve en la B del ABC con descompresión inmediata (punción o toracostomía), sin esperar imágenes.

4.02.2.015 Trauma raquimedular

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Sospechar lesión de columna en todo politraumatizado, caída de altura, zambullida en agua poco profunda o compromiso de conciencia: collar cervical, tabla espinal y movilización en bloque.
- Clínica medular: déficit motor y sensitivo bajo un nivel, arreflexia flácida (shock espinal), priapismo, respiración diafragmática en lesión cervical, retención urinaria.
- Shock neurogénico: hipotensión con bradicardia y piel tibia y seca por pérdida del tono simpático (lesión cervical o torácica alta); descartar antes hemorragia oculta.
- Manejo inicial: ABCDE con restricción de movimiento cervical (tracción mandibular, sin hiperextender), oxígeno, volumen cauteloso y vasopresor (noradrenalina), atropina si la bradicardia es sintomática; sonda vesical si no hay uretrorragia.
- Imágenes: radiografía lateral cervical no basta; TAC de columna (y RM si hay déficit neurológico).
- Seguimiento: derivar urgente a centro con neurocirugía o traumatología de columna.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 39

Una paciente de 67 años consulta por dolor de espalda, que inició de manera súbita, en relación a actividades en las que levantaba peso en flexión. El dolor es intenso, por lo que limita sus actividades de la vida diaria. Al examen físico, se observa dolor a los movimientos de flexoextensión de la columna y se observa tórax encorvado, pero sin cifosis. Su examen neurológico es normal y presenta dolor a la palpación vertebral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Lumbago mecánico
B) Lumbociática mecánica
C) Fractura de cuerpo vertebral
D) Espondiloartrosis lumbar
E) Espondilitis anquilosante

Respuesta C. Aunque al inicio parece un lumbago mecánico, la edad, el tórax encorvado y el dolor a la palpación vertebral sugieren una fractura vertebral.

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años se lanza de cabeza a una piscina poco profunda. Llega inmovilizado con collar cervical. Vía aérea permeable, respira con patrón diafragmático, PA 80/45 mmHg, FC 52 lpm, piel tibia y seca. No mueve las 4 extremidades, tiene anestesia bajo las clavículas y priapismo. FAST negativo y sin otras lesiones evidentes. **¿Cuál es la causa más probable de la hipotensión?**

A) Shock neurogénico por lesión medular cervical
B) Shock hemorrágico por lesión abdominal oculta
C) Shock espinal sin repercusión hemodinámica
D) Neumotórax a tensión
E) Taponamiento cardíaco

Respuesta A. Hipotensión con bradicardia y piel tibia en un trauma cervical con tetraplejia es shock neurogénico: pérdida del tono simpático. Se maneja con volumen cauteloso y vasopresores, manteniendo restricción de movimiento de la columna. El shock hemorrágico da taquicardia y piel fría; el shock espinal es la arreflexia transitoria, no un estado hemodinámico.

Conocimientos generales 7 códigos

4.02.3.001 Accidentes del trabajo

Dónde se enseña: Tema 21.14 Legislación Sanitaria Especial: Ley IVE 21.030, Código Sanitario y Licencias Médicas

QUÉ HAY QUE SABER

- Ley 16.744: seguro obligatorio contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, financiado por el empleador y administrado por mutualidades o el ISL.
- Accidente del trabajo: lesión sufrida a causa o con ocasión del trabajo que produce incapacidad o muerte; incluye el accidente de trayecto directo entre la casa y el trabajo.
- Ante un accidente laboral: atender la urgencia, emitir la denuncia individual de accidente del trabajo (DIAT) y derivar al organismo administrador (mutual o ISL), que cubre atención, licencia y prestaciones económicas.
- No corresponde licencia común de FONASA o ISAPRE para un accidente laboral; la enfermedad profesional se califica por el organismo administrador o COMPIN.
- Prevención: uso de elementos de protección personal, capacitación, comités paritarios y vigilancia de riesgos (caídas de altura, maquinaria, ergonomía).
- La licencia médica es un documento legal: emitirla sin evaluación clínica real es delito.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Trabajadora de 40 años, contratada en una empresa, sufre una caída en la vía pública mientras se dirigía directamente desde su casa a su lugar de trabajo. Consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por dolor en el tobillo; la radiografía muestra una fractura de maléolo lateral. **Según la Ley 16.744, ¿cómo se clasifica y maneja este evento?**

A) Enfermedad común; licencia médica tipo 1 cubierta por FONASA o ISAPRE
B) No tiene cobertura porque ocurrió fuera del lugar de trabajo
C) Accidente de trayecto; se considera accidente del trabajo y debe ser cubierto por su organismo administrador (mutualidad o ISL)
D) Enfermedad profesional; requiere evaluación por COMPIN
E) Accidente escolar; cubierto por el seguro escolar

Respuesta C. La Ley 16.744 considera accidente del trabajo al ocurrido en el trayecto directo entre la habitación y el lugar de trabajo. Se notifica (DIAT) y la atención, el subsidio y la licencia tipo 5-6 son de cargo del organismo administrador del seguro (mutualidad o ISL), no de la previsión común.

4.02.3.002 Complicaciones de la inmovilización con yeso

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización

QUÉ HAY QUE SABER

- Síndrome compartimental: dolor desproporcionado que no cede con analgesia, parestesias, dolor al estiramiento pasivo y tensión bajo el yeso en las primeras horas → retirar el yeso de inmediato y fasciotomía si no mejora.
- Prevención: en fractura reciente usar valva o férula no circular, elevar la extremidad, mover los dedos y vigilar dolor, color, temperatura y llene capilar; el yeso circular se coloca cuando cede el edema.

- Lesiones por presión y úlceras cutáneas; compresión del nervio peroneo en la cabeza del peroné (pie caído).
- Trombosis venosa profunda por inmovilización prolongada de extremidad inferior: considerar tromboprofilaxis según riesgo.
- Rigidez articular y atrofia muscular por inmovilización prolongada; distrofia simpático refleja (dolor urente, alodinia, cambios tróficos, osteoporosis moteada semanas después).
- Contractura isquémica de Volkmann (mano en garra) como secuela de un síndrome compartimental no tratado.

PREGUNTAS (3)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 4**
> Un paciente de 20 años hace 12 horas sufre una fractura cerrada de pierna derecha, mientras jugaba fútbol, presentando dolor e impotencia funcional. Se administran analgésicos y su fractura es inmovilizada con una bota larga de yeso. Sin embargo, evoluciona con intenso dolor de la pierna, más edema del pie ipsilateral. **La conducta inicial más adecuada es:**
> **A)** Solicitar nuevas radiografías
> **B)** Administrar diuréticos
> **C)** Elevar la extremidad
> **D)** Solicitar TAC de pierna
> **E)** Retirar inmediatamente el yeso
> Respuesta E. La sospecha clínica es de síndrome compartimental. La conducta adecuada es retirar el yeso de inmediato y pedir evaluación urgente por un traumatólogo para una fasciotomía amplia. El diagnóstico es clínico, aunque se puede medir la presión intracompartimental si hay un tonómetro disponible.

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 57**
> Mujer de 40 años con fractura de muñeca que fue enyesada. 3 horas después refiere dolor intenso progresivo en el antebrazo que no cede con analgesia, parestesias y sensación de tensión bajo el yeso. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Síndrome compartimental agudo
> **B)** Trombosis venosa profunda
> **C)** Reacción alérgica al yeso
> **D)** Fractura secundaria
> **E)** Distrofia simpática refleja
> Respuesta A. Dolor desproporcionado, parestesias y tensión bajo el yeso en una extremidad inmovilizada son un síndrome compartimental agudo. Es una emergencia: se retira el yeso de inmediato y se hace fasciotomía si no mejora.

> **Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar**
> Paciente con fractura de muñeca enyesada; 5 horas después presenta dolor intenso, hipoestesia y llene capilar enlentecido. ¿Diagnóstico más probable?
> **A)** Síndrome compartimental agudo
> **B)** Trombosis venosa profunda del miembro superior
> **C)** Lesión arterial por el yeso
> **D)** Compresión del nervio radial
> **E)** Reacción alérgica al yeso
> Respuesta A. Diagnóstico: Síndrome compartimental agudo (opción A). Síndrome compartimental agudo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

`4.02.3.003` Factores de riesgo de artrosis

Dónde se enseña: Tema 9.4 Artrosis / Osteoartritis: Diagnóstico Clínico, Radiología y Terapia Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- No modificables: edad (el factor más importante), sexo femenino, genética y antecedente familiar.
- Modificables: obesidad (principal factor modificable de artrosis de rodilla, por carga y efecto inflamatorio), sobrecarga laboral o deportiva y debilidad muscular del cuádriceps.
- Secundarios: fracturas con rasgo intraarticular, luxaciones crónicas, lesiones meniscales o ligamentosas, malalineación (genu varo/valgo), displasia de cadera.
- Artropatías previas: artritis reumatoide, artritis séptica, gota, hemofilia (hemartrosis repetidas), condrocalcinosis.
- Prevención: bajar 5–10 % del peso, ejercicio aeróbico y fortalecimiento de cuádriceps, calzado amortiguado y tratamiento adecuado de fracturas articulares y displasia de cadera.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 62 años consulta por dolor mecánico de ambas rodillas de 2 años de evolución, rigidez matinal menor de 30 minutos y crujidos. IMC 34 kg/m2. Trabajó 30 años como empleada doméstica. Su madre tuvo artrosis de rodillas. **¿Cuál de sus factores de riesgo de artrosis de rodilla es modificable y su intervención tiene mayor impacto en los síntomas?**
> **A)** Sexo femenino
> **B)** Obesidad
> **C)** Edad mayor de 60 años
> **D)** Antecedente familiar de artrosis
> **E)** Antecedente laboral
> Respuesta B. La obesidad es el principal factor de riesgo modificable de artrosis de rodilla: aumenta la carga articular y tiene efecto inflamatorio. Bajar al menos 5% a 10% del peso, junto con ejercicio de fortalecimiento de cuádriceps, reduce dolor y mejora función. Edad, sexo y genética no son modificables.

4.02.3.004 Factores de riesgo de osteoporosis

Dónde se enseña: Tema 9.24 Osteoporosis y Salud Ósea: Densitometría (T-score vs Z-score), Fracturas por Fragilidad, FRAX y Terapia Farmacológica

QUÉ HAY QUE SABER

- No modificables: edad avanzada, sexo femenino, menopausia (especialmente precoz), raza blanca o asiática, antecedente familiar de fractura de cadera, fractura previa por fragilidad.
- Modificables: bajo peso (IMC <19), tabaquismo, alcohol, sedentarismo, baja ingesta de calcio y déficit de vitamina D.
- Fármacos: glucocorticoides (≥5 mg/día de prednisona por ≥3 meses, la causa más frecuente de osteoporosis secundaria), anticonvulsivantes, inhibidores de aromatasa, exceso de levotiroxina.
- Enfermedades: hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, hipogonadismo, celiaquía, artritis reumatoide, mieloma, ERC.
- Evaluación: FRAX (fractura mayor ≥20 % o cadera ≥3 % indica tratamiento) y densitometría (T-score ≤ –2,5); una fractura por fragilidad basta para diagnosticar osteoporosis.
- Prevención: calcio 1.000–1.200 mg/día, vitamina D 800–2.000 UI/día, ejercicio con carga, dejar el tabaco y prevención de caídas.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Mujer de 58 años, menopausia a los 50 años, consulta para control. Es delgada (IMC 19 kg/m2) y tiene los antecedentes que se listan abajo. **¿Cuál de los siguientes antecedentes constituye el factor de riesgo de osteoporosis y fractura más relevante?**
> **A)** Uso de anticonceptivos orales durante 10 años en la juventud
> **B)** Consumo de 2 tazas de café al día
> **C)** Hipertensión arterial tratada con hidroclorotiazida
> **D)** Uso de prednisona 10 mg al día durante los últimos 6 meses por polimialgia reumática
> **E)** Sobrepeso en la adolescencia
> Respuesta D. Los glucocorticoides orales en dosis de 5 mg o más de prednisona por 3 meses o más son la causa más frecuente de osteoporosis secundaria y elevan el riesgo de fractura desde los primeros meses; obligan a densitometría y prevención. Las tiazidas incluso reducen la calciuria; el café moderado y los anticonceptivos no son factores relevantes.

4.02.3.005 Lumbociática radicular

Dónde se enseña: Tema 12.11 Patología Osteomuscular No Traumática: Lumbago, Hombro Doloroso, Tendinitis & Bursitis

QUÉ HAY QUE SABER

- Lumbociática radicular: dolor lumbar irradiado bajo la rodilla por compresión radicular, habitualmente hernia del núcleo pulposo L4-L5 o L5-S1, frecuente tras levantar peso.
- Raíces: L5 dorso del pie y ortejo mayor, debilidad del extensor del hallux; S1 planta y borde lateral, aquiliano disminuido; L4 reflejo rotuliano disminuido.

- Banderas rojas: síndrome de cauda equina (anestesia en silla de montar, alteración esfinteriana) o déficit motor progresivo → derivación urgente y RM.
- Sin déficit: manejo médico 4–6 semanas con analgesia y mantenerse activo; la mayoría mejora.
- Prevención: higiene postural y técnica correcta para levantar peso, fortalecimiento de musculatura lumbar y abdominal, control de peso.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 38 años presenta lumbago de inicio tras levantar peso hace 10 días, irradiado por la cara posterolateral del muslo y la pierna hasta el dorso del pie y el ortejo mayor derechos, con parestesias en esa zona. Lasègue positivo a 40°. Debilidad leve de la dorsiflexión del ortejo mayor. Reflejos aquilianos simétricos. Sin alteración esfinteriana ni anestesia en silla de montar. **¿Qué raíz está más probablemente comprometida y cuál es la conducta inicial?**
> **A)** S1; resonancia magnética urgente
> **B)** S1; reposo absoluto en cama por 2 semanas
> **C)** L4; cirugía descompresiva electiva
> **D)** L5; resonancia magnética urgente y cirugía
> **E)** L5; tratamiento médico con analgesia y actividad según tolerancia
> Respuesta E. Dolor hasta el dorso del pie y ortejo mayor, debilidad del extensor del hallux y aquiliano normal indican radiculopatía L5 (hernia L4-L5). Sin déficit progresivo ni síndrome de cauda equina, el manejo inicial es médico por 4 a 6 semanas, con analgesia y mantenerse activo; la resonancia se reserva para banderas rojas o falla del tratamiento.

`4.02.3.006` Prevención de displasia de cadera (diagnóstico precoz)

Dónde se enseña: Tema 18.22 Displasia del Desarrollo de la Cadera (DDC GES N° 23): Maniobras de Ortolani y Barlow, Radiografía a los 3 Meses y Correas de Pavlik

QUÉ HAY QUE SABER

- Displasia del desarrollo de la cadera: problema de salud GES; el diagnóstico precoz evita artrosis precoz, cojera y cirugía.
- Examen de caderas en todos los controles: Ortolani y Barlow bajo los 3 meses; abducción limitada y signo de Galeazzi después.
- Tamizaje universal con radiografía de pelvis a los 3 meses en todos los lactantes, tengan o no factores de riesgo.
- Factores de riesgo (sexo femenino, presentación podálica, antecedente familiar) o examen alterado bajo 3 meses: ecografía y derivación precoz.
- Tratamiento precoz con arnés de Pavlik antes de los 6 meses; evitar el envolvimiento apretado con caderas en extensión y aducción.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 40**
> Niño de 3 meses, radiografía anteroposterior de pelvis como tamizaje para displasia de cadera. Ángulo acetabular: 26 grados a derecha y 28 grados a izquierda. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Derivar a traumatología infantil
> **B)** Indicar doble pañal
> **C)** Indicar arnés de Pavlik
> **D)** Realizar ecografía de cadera
> **E)** Mantener los controles habituales de niño sano
> Respuesta E. A los 3 meses, un índice acetabular de 30 grados o menos en ambas caderas es normal. No hay displasia que tratar ni que confirmar con otro examen: se continúa con los controles habituales.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 3 meses con radiografía de pelvis con ángulos acetabulares bajo 30° bilaterales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar arnés de Pavlik de inmediato
B) Mantener controles habituales
C) Derivar a traumatología pediátrica urgente
D) Solicitar ecografía de caderas
E) Iniciar tracción cutánea

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Mantener controles habituales (opción B). Mantener controles habituales. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

4.02.3.007 Triage

Dónde se enseña: Tema 11.9 Evaluación Inicial del Politraumatizado: Protocolo ATLS (A-B-C-D-E)

QUÉ HAY QUE SABER

- Triage: clasificación de víctimas según gravedad y probabilidad de sobrevida para priorizar la atención en incidentes con múltiples víctimas.
- Triage START: quien camina es verde (diferido).
- Si no camina: sin respiración tras abrir la vía aérea es negro; FR >30/min es rojo.
- Luego perfusión: llene capilar >2 s o sin pulso radial es rojo; luego estado mental: no obedece órdenes simples es rojo.
- Si no camina pero pasa todos los criterios (FR ≤30, perfusión adecuada, obedece órdenes): amarillo (urgente, no inmediato).
- Durante el triage solo se hacen maniobras salvadoras breves (abrir vía aérea, comprimir hemorragias) y se reevalúa periódicamente.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Se produce un choque de un bus con múltiples víctimas. Usted llega primero al lugar y aplica triage START. Un hombre adulto no puede caminar, respira espontáneamente con una frecuencia de 24 por minuto, tiene llene capilar menor de 2 segundos y obedece órdenes simples. **¿Qué categoría de triage le corresponde?**

A) Verde (leve, puede esperar)
B) Amarilla (diferible)
C) Roja (inmediata)
D) Negra (fallecido o no recuperable)
E) Roja, porque no puede caminar

Respuesta B. En START, quien camina es verde. Si no camina, se evalúa: sin respiración tras abrir la vía aérea es negra; frecuencia respiratoria mayor de 30, llene capilar mayor de 2 segundos (o sin pulso radial) o no obedece órdenes es roja. Este paciente no camina pero pasa todos los criterios: amarilla.

Exámenes e imagenología 9 códigos

4.02.4.001 Radiografía de columna vertebral

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 12.15 Lumbago, Cervicalgia & Hombro Doloroso: Manguito Rotador y Capsulitis Adhesiva

QUÉ HAY QUE SABER

- El lumbago agudo mecánico sin banderas rojas no requiere imágenes: la radiografía no cambia el manejo, irradia y muestra hallazgos degenerativos irrelevantes.
- Indicaciones: trauma significativo, adulto mayor con sospecha de fractura osteoporótica (aplastamiento vertebral), sospecha de cáncer o infección, o dolor persistente >4–6 semanas pese a tratamiento.
- Hallazgos a reconocer en el informe: aplastamiento vertebral, listesis, escoliosis (ángulo de Cobb), lesiones líticas o blásticas, pinzamiento discal y osteofitos.
- Radiografía lateral cervical normal no descarta lesión en trauma: con sospecha se completa con TAC.

- Infección (espondilodiscitis), compresión medular o radiculopatía con déficit: la RM es el examen de elección, la radiografía se altera tarde.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 35 años consulta por lumbago de 5 días tras levantar una caja. Sin irradiación, sin fiebre, sin baja de peso, sin antecedente de cáncer ni de trauma mayor, sin déficit neurológico. Pide que le tomen una radiografía de columna lumbar. **¿Cuál es la conducta más adecuada respecto a las imágenes?**
> **A)** No solicitar imágenes; reevaluar si persiste más de 4 a 6 semanas o aparecen banderas rojas
> **B)** Resonancia magnética lumbar
> **C)** Radiografía lumbar AP y lateral para descartar fractura
> **D)** TAC de columna lumbar
> **E)** Radiografía lumbar con proyecciones oblicuas
> Respuesta A. El lumbago agudo inespecífico sin banderas rojas no requiere imágenes: la radiografía no cambia el manejo, irradia y detecta hallazgos degenerativos irrelevantes. Se indica radiografía ante trauma significativo, edad avanzada con sospecha de fractura osteoporótica, sospecha de cáncer o infección, o dolor persistente pese a tratamiento.

4.02.4.002 Radiografía de pelvis-caderas ante sospecha de fractura

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: adulto mayor con caída, dolor inguinal e imposibilidad de apoyar, o politraumatizado (pelvis AP en la evaluación primaria).
- Solicitar pelvis AP (compara ambas caderas y busca fractura contralateral) más cadera AP y axial; no radiografía de fémur ni resonancia como primer examen.
- Reconocer: fractura de cuello femoral (intracapsular, riesgo de necrosis avascular si está desplazada), intertrocantérica (extracapsular), y luxación de la cabeza femoral.
- Pelvis: diástasis de la sínfisis (libro abierto), fracturas de ramas y del anillo pelviano; si hay shock no retrasar la estabilización por imágenes.
- Si la radiografía es normal y la sospecha persiste, TAC o RM para fractura oculta.
- La interpretación define la cirugía: prótesis en cuello desplazado en mayor de 65 años, osteosíntesis en los demás.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un adulto mayor de 70 años con osteoporosis sufre una caída y no puede caminar. Al examen presenta abducción, rotación externa y acortamiento de la extremidad derecha. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**
> **A)** Luxación posterior de cadera; TAC de cadera
> **B)** Fractura de cadera; radiografía anteroposterior de cadera y pelvis
> **C)** Fractura de cadera; resonancia magnética de cadera
> **D)** Fractura de fémur; radiografía de fémur en dos proyecciones
> **E)** Coxartrosis aguda; radiografía de pelvis
> Respuesta B. La posición impúdica con rotación externa y acortamiento, tras una caída en un adulto mayor osteoporótico, es una fractura de cadera. Se diagnostica con radiografía de cadera anteroposterior y axial más pelvis anteroposterior. La resonancia es para partes blandas, y la luxación posterior tiene posición púdica.

4.02.4.003 Radiografía huesos largos ante sospecha de fractura

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización · Tema 12.7 Fracturas de Extremidad Inferior: Pierna, Tobillo & Esguince

QUÉ HAY QUE SABER

- Solicitar al menos dos proyecciones perpendiculares (AP y lateral) que incluyan las articulaciones proximal y distal al foco.

- Describir: hueso y segmento (epífisis, metáfisis, diáfisis), trazo (transverso, oblicuo, espiroideo, conminuto, segmentario), desplazamiento, angulación, acortamiento y compromiso articular.
- Reglas de Ottawa en tobillo: radiografía si hay dolor óseo en maléolos o base del 5° metatarsiano, o no puede dar 4 pasos.
- En niños: reconocer fracturas en tallo verde, rodete (torus) y disyunciones epifisarias (Salter-Harris); comparar con el lado sano si hay duda.
- Fractura patológica: lesión lítica o blástica previa en el foco, trauma mínimo; signos de agresividad obligan a derivar.
- Rasgo intraarticular o luxación asociada: TAC para planificar cirugía.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 7**
> Una paciente de 68 años hace dos días sufre torsión del tobillo derecho, mientras bajaba escaleras. Evoluciona con intenso dolor, que le dificulta caminar. Al examen físico presenta edema de tobillo derecho, con equimosis bimaleolar, asociado a dolor a la palpación fibular ipsilateral. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**
> **A)** Indicar inmovilizador de tobillo
> **B)** Inmovilizar con bota larga de yeso
> **C)** Solicitar radiografías de tobillo
> **D)** Solicitar TAC de tobillo
> **E)** Indicar reposo y analgesia, con elevación de la extremidad
> Respuesta C. La sospecha es una fractura de tobillo, principalmente por el dolor a la palpación ósea. Sin embargo, tanto en un esguince como en una sospecha de fractura, la conducta inicial es descartar la fractura con radiografías de tobillo (AP, lateral y oblicua).

> **Pregunta de práctica**
> Un hombre de 30 años llega a urgencias tras un accidente de tránsito con dolor e impotencia funcional en el antebrazo derecho, con deformidad visible y crepitación al examen. **¿Cuál es el diagnóstico y el estudio inicial?**
> **A)** Contusión de antebrazo; ecografía de partes blandas
> **B)** Fractura de antebrazo; radiografías anteroposterior y lateral
> **C)** Luxación de codo; TAC de antebrazo
> **D)** Fractura de antebrazo; solo radiografía anteroposterior
> **E)** Contusión grave; solo analgesia y observación
> Respuesta B. Dolor, deformidad, impotencia funcional y crepitación son la clínica clásica de fractura. Se confirma con radiografías en dos proyecciones, anteroposterior y lateral. Una sola proyección no basta.

`4.02.4.004` Radiografía de displasia cadera

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 12.14 Ortopedia Infantil: Displasia de Cadera, Escoliosis, Pie Bot & Cadera Dolorosa del Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile se tamiza con radiografía de pelvis AP a los 3 meses a todos los lactantes; bajo los 3 meses se usa ecografía.
- Trazar la línea de Hilgenreiner (horizontal por los cartílagos trirradiados) y la de Perkins (vertical desde el borde lateral del acetábulo): el núcleo o metáfisis debe quedar en el cuadrante ínfero-interno.
- Índice acetabular normal ≤30°; >30° sugiere displasia (>36° la confirma según el libro).
- Otros signos: núcleo o metáfisis desplazados hacia arriba y afuera, ruptura del arco de Shenton, retraso de osificación del núcleo respecto al lado sano.
- La ausencia del núcleo de osificación a los 3 meses puede ser normal y no indica por sí sola luxación.
- Radiografía alterada: derivar a ortopedia infantil para tratamiento con arnés de Pavlik.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Lactante de 3 meses, sexo femenino, primera hija, nacida en presentación podálica, asiste a control de salud. El examen de caderas muestra leve limitación de la abducción izquierda, sin signos de Ortolani ni Barlow. Según la normativa ministerial, corresponde el tamizaje por imagen a esta edad. **¿Qué hallazgo de la radiografía de pelvis apoya el diagnóstico de displasia de cadera?**
> **A)** Índice acetabular aumentado, sobre 30 grados, con la metáfisis femoral desplazada hacia afuera de la línea de Perkins y ruptura del arco de Shenton
> **B)** Índice acetabular de 20 grados con el núcleo femoral en el cuadrante inferior interno
> **C)** Ausencia de núcleo de osificación de la cabeza femoral, que siempre indica luxación
> **D)** Línea de Hilgenreiner que pasa por ambos cartílagos trirradiados
> **E)** Densidad ósea disminuida en ambas caderas
> Respuesta A. En Chile se tamiza con radiografía de pelvis a los 3 meses. Sugieren displasia un índice acetabular mayor de 30 grados, la metáfisis o el núcleo femoral fuera del cuadrante inferointerno formado por las líneas de Hilgenreiner y Perkins, y la ruptura del arco de Shenton. La ausencia del núcleo de osificación puede ser normal a esta edad.

4.02.4.005 Radiografía en tumores oseos

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 12.13 Tumores Óseos Benignos y Malignos: Osteocondroma, Osteoma Osteoide, Osteosarcoma & Ewing

QUÉ HAY QUE SABER

- Evaluar tres datos: edad del paciente, ubicación en el hueso (epífisis, metáfisis, diáfisis) y aspecto radiológico.
- Benignidad: bordes bien delimitados con halo esclerótico, cortical respetada o adelgazada, sin invasión de partes blandas ni reacción perióstica compleja.
- Malignidad: bordes mal definidos, cortical rota, masa de partes blandas, reacción perióstica en sol naciente, triángulo de Codman o telas de cebolla.
- Patrones: osteocondroma (exostosis desde la metáfisis); osteoma osteoide (nidus radiolúcido <1 cm con esclerosis); osteosarcoma (metáfisis del adolescente, sol naciente); Ewing (diáfisis del niño, telas de cebolla); células gigantes (epífisis del adulto, lítico en pompas de jabón).
- Metástasis: lesiones líticas o blásticas múltiples en adulto; mieloma con lesiones en sacabocado.
- Aspecto agresivo: derivar a centro especializado para RM de todo el hueso, TAC de tórax y biopsia.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Adolescente de 15 años consulta por dolor en la rodilla izquierda de 2 meses, que lo despierta en la noche, y aumento de volumen. La radiografía muestra en la metáfisis distal del fémur una lesión de bordes mal definidos, con destrucción cortical, formación de hueso en rayos de sol y un triángulo de Codman. **¿Cuál es la interpretación radiológica y el diagnóstico más probable?**
> **A)** Lesión benigna de márgenes escleróticos; osteocondroma
> **B)** Nidus radiolúcido menor de 1 cm con esclerosis; osteoma osteoide
> **C)** Lesión lítica central bien delimitada; quiste óseo simple
> **D)** Lesión agresiva con reacción perióstica maligna; osteosarcoma
> **E)** Lesión epifisaria en pompas de jabón; tumor de células gigantes
> Respuesta D. Bordes mal definidos, rotura cortical, reacción perióstica en rayos de sol y triángulo de Codman son signos radiológicos de agresividad. En la metáfisis de un adolescente, el diagnóstico más probable es osteosarcoma; se deriva para resonancia de todo el hueso, TC de tórax y biopsia en centro especializado.

4.02.4.006 Set radiológico de trauma en conjunto (columna cervical, tórax, pelvis y columna)

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 12.5 Fracturas de Pelvis & Shock Hipovolémico Pelviano: Clasificación Tile / Young-Burgess & Estabilización Precoz

QUÉ HAY QUE SABER

- Todo politraumatizado lleva radiografía de columna cervical lateral, tórax AP y pelvis AP, aunque esté estable o asintomático.

- Cervical lateral: debe verse de C1 hasta C7-T1; evaluar alineación de las cuatro líneas, cuerpos vertebrales y partes blandas prevertebrales. Normal no descarta lesión: con sospecha completar con TAC y mantener el collar.
- Tórax AP: neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar, fracturas costales, ensanchamiento mediastínico (lesión aórtica), posición del tubo endotraqueal.
- Pelvis AP: fracturas del anillo pelviano y diástasis de sínfisis (libro abierto), que explican shock hipovolémico.
- Columna toracolumbar: según mecanismo y examen, idealmente con TAC.
- Si el paciente está inestable, las imágenes no deben retrasar la reanimación (neumotórax a tensión se descomprime clínicamente).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Un paciente politraumatizado llega a urgencias tras un accidente de tránsito. **¿Cuáles son las tres radiografías mínimas que se deben solicitar?**
> **A)** Anteroposterior de tórax, anteroposterior de abdomen y lateral de rodilla
> **B)** Lateral de cuello, anteroposterior de tórax y anteroposterior de pelvis
> **C)** Anteroposterior de tórax, TAC de cerebro y anteroposterior de pelvis
> **D)** Solo anteroposterior de tórax si el paciente está estable
> **E)** Radiografías de todos los huesos largos más AP de tórax
> Respuesta B. Las tres radiografías mínimas son lateral de cuello, para fractura cervical, AP de tórax, para neumotórax o hemotórax, y AP de pelvis, para fractura de pelvis. Se piden siempre, aunque el paciente esté estable.

4.02.4.007 Citoquimico de líquido articular

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicación: toda monoartritis aguda o derrame articular no filiado, antes del antibiótico.
- No inflamatorio (tipo I): 200–2.000 leucocitos, PMN <25 %, glucosa igual a la sangre: artrosis o causa mecánica.
- Inflamatorio (tipo II): 2.000–50.000 leucocitos: cristales (gota con agujas de birrefringencia negativa; pseudogota con romboidales débilmente positivos) o artritis reumatoide.
- Séptico (tipo III): >50.000 leucocitos, PMN >90 %, glucosa <50 % de la glicemia, turbio: hospitalizar, antibióticos EV y drenaje.
- Hemorrágico: trauma con lesión ligamentosa, fractura (gotas de grasa) o coagulopatía (hemofilia).
- Trampa: los cristales no descartan infección (pueden coexistir) y una crisis gotosa puede superar 50.000 leucocitos.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 60 años, diabético, consulta por dolor, calor y aumento de volumen de la rodilla izquierda de 2 días, con fiebre de 38,6 grados. Se realiza artrocentesis, que obtiene líquido turbio. Citoquímico: 85.000 leucocitos por mm3 con 92% de polimorfonucleares, glucosa 20 mg/dL (glicemia 160 mg/dL). No se observan cristales. Gram pendiente. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**
> **A)** Líquido no inflamatorio por artrosis; paracetamol y kinesioterapia
> **B)** Líquido séptico; hospitalizar, tomar hemocultivos, iniciar antibióticos endovenosos empíricos y drenaje articular
> **C)** Gota aguda; colchicina y alta
> **D)** Líquido hemorrágico; reposo y frío local
> **E)** Líquido inflamatorio leve; infiltrar corticoides intraarticulares
> Respuesta B. Un líquido articular turbio con más de 50.000 leucocitos por mm3, predominio polimorfonuclear sobre 90% y glucosa muy baja respecto de la sangre es séptico hasta demostrar lo contrario. Se hospitaliza, se cultiva, se inician antibióticos empíricos con cobertura de Staphylococcus aureus y se drena. Los corticoides intraarticulares están contraindicados.

4.02.4.008 Cultivo y antibiograma en infecciones osteoarticulares y heridas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 9.2 Artritis Séptica del Adulto y Protésica: Etiología, Drenaje Urgente y Antimicrobianos

QUÉ HAY QUE SABER

- En sospecha de artritis séptica u osteomielitis, tomar hemocultivos (×2) y cultivo del líquido articular o de tejido óseo antes del primer antibiótico, porque este negativiza los cultivos.
- El cultivo demora 48–72 h: no se espera para iniciar antibiótico empírico; el antibiograma permite ajustar (S. aureus sensible a cefazolina/cloxacilina; SAMR a vancomicina).
- En osteomielitis la muestra válida es ósea (biopsia o quirúrgica); el hisopado superficial de piel o fístula no representa al germen profundo.
- Heridas: cultivar solo heridas con signos de infección, tras limpiar, de tejido profundo o pus; no se cultivan heridas limpias.
- Interpretar: S. aureus es el agente más frecuente; gonococo crece mal (pedir cultivo en medio especial y de mucosas); Gram negativo no descarta infección.
- Ajustar el esquema y la duración según germen y sensibilidad informados.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 55 años, diabético, consulta por rodilla derecha caliente, roja y con derrame de 2 días, fiebre de 38,8 °C. Está hemodinámicamente estable. Se planifica tratamiento antibiótico endovenoso. **¿Qué se debe hacer antes de iniciar los antibióticos?**
>
> **A)** Nada; el inicio de antibióticos no debe retrasarse por ningún examen
> **B)** Tomar cultivo de un hisopado de la piel sobre la rodilla
> **C)** Solicitar resonancia magnética de rodilla
> **D)** Tomar hemocultivos y artrocentesis con Gram y cultivo del líquido articular
> **E)** Esperar resultado de la VHS y PCR
>
> Respuesta D. En la sospecha de artritis séptica en un paciente estable, se toman hemocultivos y se punciona la articulación (Gram, cultivo, recuento celular y cristales) antes del primer antibiótico, porque este negativiza los cultivos. El antibiograma permite ajustar el esquema empírico. El hisopado de piel no representa al germen articular.

4.02.4.009 Gram líquido articular

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 9.1 Monoartritis Aguda: Enfrentamiento Clínico y Estudio de Líquido Sinovial

QUÉ HAY QUE SABER

- Tinción rápida del líquido sinovial que orienta el antibiótico empírico mientras llega el cultivo.
- Cocos grampositivos en racimo: S. aureus (el más frecuente); en cadena: estreptococos; diplococos gramnegativos intracelulares: gonococo; bacilos gramnegativos en ancianos, ITU o usuarios de drogas EV.
- Es específico pero poco sensible (~50 %; menos del 25 % en gonococo): un Gram negativo no descarta artritis séptica.
- Con líquido >50.000 leucocitos y fiebre se trata como séptica aunque el Gram sea negativo o haya cristales, hasta el resultado del cultivo.
- Se interpreta junto con el citoquímico y la búsqueda de cristales con luz polarizada.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 70 años con monoartritis aguda de rodilla izquierda y fiebre. La artrocentesis obtiene líquido turbio con 65.000 leucocitos/mm3, 92% polimorfonucleares. Se observan cristales romboidales con birrefringencia positiva débil. El Gram es negativo (no se observan bacterias). **¿Cuál es la interpretación más adecuada?**
>
> **A)** Pseudogota; el Gram negativo descarta infección
> **B)** Artritis séptica descartada; iniciar colchicina
> **C)** No se puede descartar artritis séptica: el Gram tiene baja sensibilidad; iniciar antibióticos empíricos hasta el resultado del cultivo
> **D)** Gota aguda; indicar AINE
> **E)** Artritis reactiva; buscar infección genitourinaria
>
> Respuesta C. El Gram del líquido sinovial es específico pero poco sensible (cerca de 50%): un Gram negativo no descarta artritis séptica. Además, cristales e infección pueden coexistir. Con líquido de más de 50.000 leucocitos y fiebre, se trata empíricamente como séptica hasta que el cultivo resulte negativo.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 5 códigos

4.02.5.001 Inmovilizaciones de urgencia

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 12.1 Principios Generales de Fracturas, Consolidación Ósea & Inmovilización · Tema 12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Objetivo: disminuir dolor, sangrado y daño de partes blandas y neurovascular, y permitir un traslado seguro.
- Antes: ABC; examinar y registrar pulsos, llene capilar, sensibilidad y motilidad distal; retirar anillos y joyas.
- Técnica: alinear con tracción suave en el eje, inmovilizar incluyendo la articulación proximal y distal al foco con férulas o valvas acolchadas no circulares; extremidad elevada.
- Ejemplos: valva antebraquiopalmar en muñeca; cabestrillo en clavícula y hombro; férula larga desde muslo a pie en pierna; collar cervical y tabla espinal en sospecha de columna.
- Fractura expuesta: no suturar, cubrir con apósito estéril, valva larga y abierta.
- Contraindicado el yeso circular cerrado y vendajes compresivos en agudo (síndrome compartimental); reevaluar el estado neurovascular después de inmovilizar.

PREGUNTAS (2)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 34 años se cae de una bicicleta y llega al SAPU con dolor y deformidad en el tercio medio de la pierna izquierda. La piel está indemne, pulsos pedios presentes, llene capilar menor de 2 segundos y sensibilidad conservada. Debe ser trasladada al hospital, a 40 minutos. **¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada antes del traslado?**
>
> **A)** Yeso circular cerrado desde el muslo hasta el pie
> **B)** Vendaje elástico compresivo solo sobre el foco de fractura
> **C)** Férula que incluya la articulación proximal y distal (rodilla y tobillo), previa alineación suave y con control neurovascular antes y después
> **D)** No inmovilizar para no retrasar el traslado
> **E)** Reducción forzada bajo anestesia local y luego traslado sin férula
>
> Respuesta C. La inmovilización de urgencia debe incluir la articulación por encima y por debajo de la fractura, alinear con tracción suave, usar férulas acolchadas no circulares y registrar el estado neurovascular antes y después. El yeso circular en agudo está contraindicado por el edema y el riesgo de síndrome compartimental.

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 26 años cae de una escalera sobre la mano extendida. Llega al SAPU con dolor y deformidad en dorso de tenedor en la muñeca derecha. Piel indemne, llene capilar normal y sensibilidad conservada en los dedos. Se decide inmovilizar antes de derivarlo para radiografía y manejo definitivo. **¿Cuál es la inmovilización de urgencia más adecuada?**
>
> **A)** Yeso circular braquiopalmar cerrado
> **B)** Vendaje elástico compresivo apretado desde la mano al codo
> **C)** Solo cabestrillo, sin férula
> **D)** Valva o férula antebraquiopalmar acolchada, sin cerrar en forma circular, con cabestrillo y control neurovascular
> **E)** Reducción forzada sin analgesia y luego vendaje
>
> Respuesta D. En urgencia se inmoviliza con férulas o valvas acolchadas no circulares que incluyan las articulaciones vecinas, dejando espacio para el edema, con elevación y registro neurovascular antes y después. El yeso circular cerrado y los vendajes compresivos en agudo arriesgan un síndrome compartimental.

4.02.5.002 Punción articular de rodilla

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 12.12 Artrosis & Monoartritis Aguda: Líquido Sinovial, Gota, Pseudogota & Artritis Séptica

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: diagnóstica en toda monoartritis o derrame no filiado (descartar artritis séptica, cristales), y evacuadora en derrame a tensión o hemartrosis. Siempre antes del antibiótico.
- Única contraindicación absoluta habitual: celulitis o infección de la piel en el sitio de punción (elegir otro abordaje). La anticoagulación en rango y la aspirina no la contraindican.

- Técnica: paciente en decúbito supino con rodilla extendida y cuádriceps relajado, asepsia rigurosa, abordaje suprapatelar lateral bajo el borde superolateral de la rótula, con aguja gruesa.
- Enviar líquido a citoquímico con recuento y diferencial, glucosa, Gram, cultivo y cristales con luz polarizada.
- No se infiltran corticoides si se sospecha artritis séptica; en hemofílicos no puncionar sin reponer factor.
- Complicaciones: infección iatrogénica, hemartrosis, dolor.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 45 años con derrame a tensión de rodilla derecha de 24 horas, sin trauma. Se decide artrocentesis diagnóstica en el servicio de urgencia. **¿Cuál de las siguientes condiciones contraindica realizar la punción por la vía planificada?**
>
> **A)** Fiebre de 38,5 °C
> **B)** Celulitis de la piel en el sitio de punción
> **C)** Uso de aspirina en dosis baja
> **D)** Antecedente de gota
> **E)** Derrame mayor de 50 mL
>
> Respuesta B. La única contraindicación absoluta habitual de la artrocentesis es la infección de piel o celulitis sobre el sitio de punción, porque se puede inocular la articulación; se elige otro abordaje. La fiebre es una indicación (descartar artritis séptica). La antiagregación o anticoagulación en rango no la contraindica. Se usa técnica aséptica, habitualmente por abordaje suprapatelar lateral.

4.02.5.003 Reducción de luxaciones de codo, hombro e interfalángicas

Nivel: **Derivar a especialista**

Dónde se enseña: Tema 12.4 Lesiones Neurovasculares de las Fracturas: Seddon, Nervio Radial & Lesión Arterial

QUÉ HAY QUE SABER

- Procedimiento que se deriva a especialista; el médico general sospecha, inmoviliza, analgesia y deriva.
- Antes de reducir: radiografía para descartar fractura asociada y examen neurovascular documentado (hombro: nervio axilar y pulsos; codo: arteria braquial, mediano y cubital).
- Hombro anterior: tracción-contratracción u otras maniobras bajo analgesia/sedación. Codo posterior: tracción longitudinal del antebrazo con contratracción y flexión progresiva. Interfalángica: tracción axial y presión sobre la falange luxada.
- Después de reducir: repetir el examen neurovascular y la radiografía de control.
- Inmovilización breve (cabestrillo en hombro, codo en flexión, sindactilia en dedos) y movilización precoz para evitar rigidez.
- Luxación posterior de cadera: reducción cerrada urgente bajo anestesia en pabellón por especialista.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Hombre de 30 años con luxación posterior de codo izquierdo tras caída, sin fracturas en la radiografía. Antes de reducir, el pulso radial está presente y la sensibilidad de la mano es normal. Se reduce mediante tracción longitudinal del antebrazo con contratracción del brazo y flexión progresiva. **Inmediatamente después de la reducción, ¿cuál es la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Dar de alta con analgesia, sin inmovilización
> **B)** Solicitar resonancia magnética urgente
> **C)** Inmovilizar con yeso en extensión por 6 semanas
> **D)** Reevaluar pulsos y función neurológica, controlar con radiografía y dejar férula braquiopalmar por un período corto
> **E)** Iniciar ejercicios de fuerza inmediatamente
>
> Respuesta D. Tras toda reducción de una luxación se debe reexaminar el estado neurovascular (la arteria braquial y los nervios mediano y cubital pueden quedar atrapados), confirmar la reducción con radiografía e inmovilizar brevemente en flexión, con movilización precoz para evitar rigidez. Inmovilizar en extensión o por largo tiempo produce rigidez.

4.02.5.004 Tracción de partes blandas

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 12.10 Fractura de Cadera en el Adulto Mayor: Clasificación, Imágenes & Cirugía

QUÉ HAY QUE SABER

- Tracción de partes blandas (cutánea): vendas adheridas a la piel con pesos bajos (hasta 3–5 kg en adultos), usada transitoriamente para alinear, disminuir el dolor y el espasmo (p. ej., fractura de cadera o fémur mientras espera cirugía).
- Técnica: piel sana e indemne, almohadillar prominencias óseas, vendaje desde el tobillo hasta bajo la rodilla o muslo, peso colgando libre en el eje.
- Complicaciones a vigilar: lesiones cutáneas por fricción o presión (flictenas, úlceras) y neuropraxia del peroneo común en la cabeza del peroné.
- Controlar periódicamente piel, sensibilidad y dorsiflexión del pie y llene capilar.
- Contraindicada sobre piel lesionada o con heridas; para pesos mayores se usa tracción esquelética (riesgo de infección del trayecto de los clavos).

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Mujer de 82 años con fractura pertrocantérea de cadera derecha espera cirugía, programada en 48 horas. Se instala tracción de partes blandas (cutánea) en la extremidad, con vendaje y peso de 3 kg. **¿Cuál es la complicación que más se debe vigilar por esta tracción?**
>
> **A)** Trombosis arterial femoral
> **B)** Osteomielitis del trayecto de los clavos
> **C)** Síndrome de embolia grasa causado por la tracción
> **D)** Luxación de la rodilla
> **E)** Lesión de la piel (flictenas, úlceras por presión) y compresión del nervio peroneo a nivel de la cabeza del peroné
>
> Respuesta E. La tracción de partes blandas usa vendas adheridas a la piel con pesos bajos (hasta 3 a 5 kg en adultos). Sus complicaciones típicas son lesiones cutáneas por fricción o presión y neuropraxia del peroneo común en la cabeza del peroné; se vigilan piel, sensibilidad y dorsiflexión. La infección del trayecto es propia de la tracción esquelética.

4.02.5.005 Traslado del traumatizado

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 12.2 Fracturas Expuestas: Clasificación Gustilo-Anderson, Antibioticoterapia EV & Aseo Quirúrgico Urgente

QUÉ HAY QUE SABER

- Antes del traslado: ABCDE y estabilización (vía aérea, control de hemorragia, dos vías venosas, volumen); coordinar con el centro receptor.
- Sospecha de lesión de columna: collar cervical rígido y tabla espinal, movilización en bloque; nunca permitir que camine ni trasladar sentado.
- Retirar el casco solo con técnica entre dos operadores manteniendo la alineación cervical; nunca tirando bruscamente.
- Inmovilizar fracturas con férulas que incluyan articulaciones vecinas; fractura expuesta con apósito estéril y valva abierta; pelvis inestable con sábana pélvica.
- Evitar hipotermia (cubrir, fluidos tibios), registrar Glasgow, signos vitales y estado neurovascular, y reevaluar durante el traslado.
- No retrasar el traslado esperando radiografías cuando el paciente requiere un centro de mayor complejidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un motociclista de 30 años choca a alta velocidad en una carretera rural. Al llegar el equipo de rescate, está confuso con Glasgow 13, se queja de dolor cervical y tiene deformidad del muslo derecho. Respira espontáneamente, presión arterial 110/70 mmHg y frecuencia cardíaca 105 por minuto. Aún tiene el casco puesto. **¿Cuál es la conducta más adecuada para su traslado?**

A) Sentarlo en el auto de un testigo para llegar más rápido al hospital

B) Mantener la vía aérea, retirar el casco entre dos personas con estabilización manual de la columna, colocar collar cervical, tabla espinal y férula de la extremidad, y trasladar monitorizado al centro adecuado

C) Retirar el casco tirando de él rápidamente para evaluar la cara

D) Esperar en el lugar a tener radiografías antes de movilizarlo

E) Trasladarlo en decúbito lateral sin inmovilización cervical para evitar aspiración

Respuesta B. Todo politraumatizado con mecanismo de alta energía, compromiso de conciencia o dolor cervical se traslada con restricción de movimiento espinal: vía aérea primero, retiro del casco entre dos operadores con estabilización manual, collar, tabla, férulas en las fracturas, oxígeno y monitorización, hacia el centro con capacidad resolutiva.